



PROPOSTA TÉCNICA E FINANCEIRA

AMAZÔNIA SEM FRONTEIRAS

Saúde, Energia Limpa e Proteção Humanitária para Migrantes e Refugiados no Acre

Proponente	Instituto de Pesquisa e Ensino Silvestre Santé - iSanté
CNPJ	40.137.545/0001-69
Endereço	Avenida Ceará, nº 3797 – Tangará – Rio Branco/AC – CEP 69.915-030
Email Institucional	isanteac@gmail.com
Telefone Institucional	(68)99996-2961
Local de Execução	Rio Branco, Acre, Amazônia brasileira
Duração	24 meses, agosto de 2026 a julho de 2028
Orçamento Global	R\$2.980.320,00
Infraestrutura Energética	Sistema solar fotovoltaico de 404,46 kWp, 4 inversores Huawei de 75 kW e BESS
Tese de Impacto	Energia limpa convertida em assistência médica humanitária gratuita para migrantes e refugiados
Responsável Técnica pela Proposta	Marilda Moreira Brasileiro Rios
Email	marilda.brasileiro@gmail.com
Telefone	(68)99996-2961
Versão	01
Data	04/06/2026



SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO ESTRATÉGICA DA PROPOSTA	4
2. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO E FICHA TÉCNICA	5
3. RESUMO EXECUTIVO	6
4. CAPACIDADE INSTITUCIONAL DO PROPONENTE	8
5. DIAGNÓSTICO TERRITORIAL, MIGRATÓRIO, SANITÁRIO E ENERGÉTICO	11
5.1. Diagnóstico territorial e migratório	11
5.2. Diagnóstico sanitário e lacunas assistenciais	12
5.3. Diagnóstico energético e justificativa de infraestrutura crítica	12
6. LINHA DE BASE	12
7. TEORIA DE MUDANÇA	15
8. OBJETIVOS	16
9. PÚBLICO-ALVO E CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE E PRIORIZAÇÃO	16
9.1. Critérios de Elegibilidade	17
9.2. Critérios de Priorização	18
9.3. Fluxo de Acesso e Encaminhamento	18
9.4. Salvaguardas de Equidade e Transparência	19
9.5. Beneficiários Diretos	19
10. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO	19
10.1. Validação Participativa da Teoria da Mudança	20
10.2. Eixo 1 - Implantação da Infraestrutura Energética Sustentável	20
10.3. Eixo 2 - Estruturação Assistencial e Protocolos de Atendimento Humanitário	21
10.4. Eixo 3 - Atendimento Humanitário em Saúde	22
10.5. Eixo 4 - Formação Profissional, Ensino e Integração Serviço-Comunidade	22
10.6. Eixo 5 - Pesquisa Aplicada e Produção de Evidências	23
10.7. Eixo 6 - Salvaguardas, Proteção e Accountability	23
10.8. Eixo 7 - Governança ESG, Monitoramento e Avaliação de Impacto	24
10.9. Fluxo Metodológico Integrado	25
10.10. Estrutura Analítica do Projeto - EAP	26
11. SOLUÇÃO ENERGÉTICA SUSTENTÁVEL E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	28
12. PLANO ASSISTENCIAL HUMANITÁRIO E INTERCULTURAL	28
12.1. Diretrizes do Atendimento Intercultural Multilíngue	29
12.2. Idiomas Prioritários e Estratégia de Comunicação	30
12.3. Mediador Cultural e Intérprete	31
12.4. Fluxo Assistencial Humanitário e Intercultural	32
12.5. Registro dos Atendimentos com Mediação Intercultural	33
12.6. Materiais Interculturais e Multilíngues	33
12.7. Salvaguardas Assistenciais no Atendimento Intercultural	34
12.8. Indicadores do Plano Assistencial Intercultural	34
13. ENSINO, PESQUISA APLICADA E PRODUÇÃO CIENTÍFICA	35
13.1. Integração Ensino-Serviço	35
13.2. Pesquisa Aplicada em Saúde Migratória	36
13.3. Ética, Consentimento e Proteção dos Participantes	36
13.4. Governança de Dados Sensíveis e LGPD	36
13.5. Anonimização, Uso de Prontuários e Acompanhamento Longitudinal	37
13.6. Plano de Publicação Responsável	37
13.7. Produtos Esperados	38
14. SALVAGUARDAS, PROTEÇÃO E ÉTICA	38
15. GOVERNANÇA ESG, ACCOUNTABILITY E PRESTAÇÃO DE CONTAS	41
15.1. Mecanismos de Accountability	44
15.2. Participação Social e Escuta dos Beneficiários	45
15.3. Prestação de Contas e Relatórios	45
16. INDICADORES DE IMPACTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO	46
16.2. Diretrizes para Gestão dos Indicadores	52
16.3. Produtos de Monitoramento e Avaliação	52
17. MATRIZ LÓGICA	54
18. PLANO ORÇAMENTÁRIO, CUSTO-EFETIVIDADE E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA	55
18.1. Composição orçamentária consolidada	56
18.2. Composição por natureza de despesa	56
18.3. Composição por fonte de financiamento	56
18.4. Memória de cálculo assistencial e custo-efetividade	57
18.5. Sustentabilidade financeira	57
19. SUSTENTABILIDADE PÓS-FINANCIAMENTO	58
20. PLANO DE REPLICABILIDADE E ESCALA	60



20.1. Estratégia de escala	61
21. PLANO DE COMUNICAÇÃO E VISIBILIDADE PARA INVESTIDORES	63
21.1. Produtos de Comunicação e Prestação de Contas	63
22. MATRIZ DE RISCOS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO	64
22.1. Matriz Quantitativa de Riscos	65
23. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO PARA ORGANISMOS INTERNACIONAIS	70
23.1. Matriz de Alinhamento com os ODS	72
24. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO COM PARCEIROS DE ENERGIA	73
24.1. Proposta de Valor para Parceiros de Energia	74
24.2. Indicadores Relevantes para Parceiros de Energia	75
24.3. Trilha de Formação em Energia Limpa, Sustentabilidade Hospitalar e ESG	75
25. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO CONSOLIDADO E DETALHADO	76
25.1. Cronograma de desembolso consolidado por ano	76
25.2. Cronograma detalhado por grupo de despesa	77
25.3. Cronograma trimestral consolidado	77
25.4. Cronograma físico-financeiro por etapa estratégica	77
26. CONCLUSÃO	78
27. MATRIZ DE ANEXOS	81



1. APRESENTAÇÃO ESTRATÉGICA DA PROPOSTA

O Projeto Amazônia Sem Fronteiras apresenta uma solução integrada, financiável e de alto valor socioambiental para migrantes e refugiados em situação de vulnerabilidade no Acre. Sua tese de impacto é clara: reduzir custos energéticos hospitalares por meio de infraestrutura renovável e converter essa eficiência em atendimento médico gratuito, mensurável e contínuo para populações deslocadas e historicamente subassistidas na Amazônia brasileira.

Concebido como modelo amazônico de saúde humanitária climaticamente resiliente, o projeto converte aporte financeiro em legado social permanente. A energia solar fotovoltaica com armazenamento por baterias deixa de ser apenas componente ambiental e passa a funcionar como infraestrutura crítica para ampliar a resposta social, assistencial e científica em território de fronteira. Seu diferencial está na combinação entre territorialidade amazônica, cuidado direto a migrantes, inovação energética, produção científica e governança de impacto. Em síntese, o projeto transforma economia energética em cuidado médico gratuito, dignidade, proteção e acesso à saúde.



2. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO E FICHA TÉCNICA

Campo	Descrição
Nome do projeto	Amazônia Sem Fronteiras - Saúde, Energia Limpa e Proteção Humanitária para Migrantes e Refugiados no Acre
Nome simplificado	Projeto Amazônia Sem Fronteiras
Proponente	Instituto de Pesquisa e Ensino Silvestre Santé - iSanté
CNPJ	40.137.545/0001-69
Local de execução	Rio Branco, Acre, Amazônia brasileira
Duração	24 meses, com execução prevista entre agosto de 2026 e julho de 2028
Público-alvo direto	Migrantes e refugiados residentes ou em trânsito no Acre, com prioridade para mulheres, crianças, gestantes, idosos, pessoas com deficiência e pessoas em maior vulnerabilidade social e sanitária
Beneficiários diretos	1.296 pessoas ao longo de 24 meses
Beneficiários indiretos	Aproximadamente 18.000 pessoas, incluindo familiares, rede pública de saúde, estudantes, profissionais e comunidade acadêmica
Orçamento global	R\$2.980.320,00
Eixo energético	Sistema solar fotovoltaico de 404,46 kWp, operação zero grid, 642 módulos bifaciais de 630 Wp, 4 inversores Huawei de 75 kW e sistema BESS
Economia energética estimada	R\$ 28.075,00 por mês e R\$ 336.900,00 por ano, em premissa conservadora
ODS prioritários	ODS 3, ODS 4, ODS 7, ODS 10, ODS 13, ODS 16 e ODS 17
Palavras-chave	Saúde humanitária; migrantes; ESG em saúde; energia renovável; sustentabilidade hospitalar; eficiência energética; impacto social; população vulnerável; saúde na Amazônia; inclusão em saúde; saúde de fronteira; desenvolvimento sustentável; pesquisa aplicada; green hospital; resiliência climática



3. RESUMO EXECUTIVO

Entre 2015 e 2026, o Acre registrou 358.439 entradas de estrangeiros, volume equivalente a aproximadamente 40,5% da população deste Estado estimada pelo IBGE para 2025, de 884.372 habitantes. Embora esse dado represente movimento migratório, e não população residente, sua magnitude evidencia a pressão territorial, social e sanitária exercida sobre um estado amazônico de baixa densidade populacional, oferta limitada de especialidades médicas e posição estratégica na fronteira internacional com Peru e Bolívia.

No mesmo período, o Acre acumulou saldo migratório estrangeiro positivo de 41.309 pessoas, com fluxos expressivos de migrantes provenientes do Peru, Bolívia, Venezuela, Haiti, Senegal, Colômbia e Equador. Esse cenário consolida o Estado como um dos principais corredores migratórios internacionais da Amazônia brasileira e reforça a necessidade de respostas qualificadas, contínuas e interculturais em saúde, proteção social e inclusão humanitária, especialmente para populações em situação de vulnerabilidade social, sanitária, econômica e documental.

Diante desse contexto, o Projeto Amazônia Sem Fronteiras propõe uma solução integrada de saúde humanitária, energia limpa, pesquisa aplicada, formação profissional e governança ESG, voltada à ampliação do acesso gratuito à assistência médica especializada para migrantes e refugiados em situação de vulnerabilidade no Estado do Acre. A iniciativa será executada pelo Instituto de Pesquisa e Ensino Silvestre Santé, em cooperação com o Hospital Silvestre Santé e a Universidade Federal do Acre, articulando capacidade assistencial instalada, produção científica, integração ensino-serviço e sustentabilidade institucional. A proposta oferece uma solução mensurável, auditável e replicável, capaz de integrar saúde, energia limpa, proteção humanitária, ciência aplicada e governança ESG na Amazônia.

O projeto prevê a implantação de um sistema solar fotovoltaico de 404,46 kWp, associado a sistema de armazenamento energético por baterias, fortalecendo a segurança energética hospitalar, reduzindo custos operacionais e criando uma base sustentável de financiamento social. A economia operacional estimada em R\$336.900,00 por ano será convertida em consultas médicas, exames laboratoriais, exames de imagem, atendimentos ambulatoriais e suporte hospitalar de urgência para migrantes e refugiados, com prioridade para mulheres, crianças, gestantes, idosos, pessoas com doenças crônicas e indivíduos em maior risco social.



A proposta estrutura um modelo ESG replicável para territórios amazônicos e fronteiriços, no qual infraestrutura sustentável gera impacto social direto, mensurável e auditável. Além da assistência em saúde, a iniciativa produzirá dados epidemiológicos sobre saúde migratória, fortalecerá a formação humanizada de estudantes da área da saúde, apoiará a redução da pressão sobre o Sistema Único de Saúde e consolidará uma metodologia de atendimento intercultural baseada em dignidade, inclusão, proteção, evidências e continuidade do cuidado. Diferentemente de iniciativas assistenciais pontuais, o projeto cria uma plataforma permanente de impacto, na qual a redução de custos operacionais gera capacidade contínua de atendimento gratuito e produção de evidências para políticas públicas.

Ao longo de 24 meses, espera-se consolidar um modelo amazônico de saúde humanitária climaticamente resiliente, capaz de demonstrar como energia limpa, ciência aplicada, governança ESG e assistência médica podem atuar de forma integrada para reduzir desigualdades, proteger populações deslocadas, ampliar o acesso à saúde especializada e fortalecer serviços essenciais em territórios de fronteira internacional.

O Amazônia Sem Fronteiras representa uma oportunidade concreta de viabilizar uma plataforma permanente capaz de transformar eficiência energética em acesso gratuito à saúde, proteção humanitária, formação profissional e evidências científicas para tomada de decisão; sintetizado no quadro a seguir:

Dimensão	O que viabiliza	Evidência de valor
Impacto social direto	Atendimento gratuito, intercultural e priorizado para migrantes e refugiados vulneráveis.	1.296 beneficiários diretos, carteira assistencial com consultas, exames, suporte hospitalar e mediação intercultural.
Legado estruturante	Infraestrutura energética permanente para reduzir custo operacional e sustentar assistência social.	Sistema fotovoltaico de 404,46 kWp com BESS e economia anual estimada de R\$336.900,00.
ESG e reputação institucional	Associação a uma solução amazônica que integra saúde, clima, proteção, ciência e governança.	Indicadores ESG, relatórios periódicos, ODS, salvaguardas e prestação de contas.
Escalabilidade	Demonstração de um modelo replicável para outros territórios amazônicos e fronteiriços.	Manualização, matriz de indicadores, plano de replicabilidade e produção de evidências.



4. CAPACIDADE INSTITUCIONAL DO PROPONENTE

O Instituto de Pesquisa e Ensino Silvestre Santé, iSanté, constitui o braço social, científico, educacional e de inovação em saúde do ecossistema Silvestre Santé, estruturado para integrar assistência especializada, pesquisa clínica aplicada, produção científica, formação profissional, educação em saúde, prevenção comunitária e desenvolvimento de projetos voltados a populações vulneráveis na Amazônia brasileira.

O Ecossistema Silvestre Santé atua regionalmente nos segmentos da saúde, ciência, inovação e impacto social sediado em Rio Branco, no Estado do Acre, com atuação estratégica na Amazônia Ocidental. Sua estrutura combina assistência médica especializada, pesquisa clínica aplicada, formação técnico-científica e iniciativas de prevenção e educação em saúde, permitindo a execução de projetos que articulam atendimento direto, geração de evidências, capacitação profissional e impacto territorial.

Do ponto de vista assistencial, a capacidade operacional disponível inclui infraestrutura hospitalar instalada de 5.468,99 m², pronto atendimento, consultórios especializados, leitos de observação e semi-intensivos, laboratório, centro de imagem com ultrassonografia, raio X e tomografia, equipe multiprofissional e experiência acumulada em ações preventivas, programas sociais, eventos científicos e pesquisas clínicas. Essa infraestrutura permite que o projeto não dependa da criação de uma nova unidade assistencial, mas utilize uma capacidade instalada existente para ampliar o acesso gratuito à saúde de migrantes e refugiados em situação de vulnerabilidade.

No campo científico, o Ecossistema Silvestre Santé apresenta trajetória consistente de produção acadêmica e pesquisa aplicada em cardiologia, com mais de 50 publicações científicas internacionais indexadas em bases como PubMed, consolidando-se como um hub de produção científica aplicada com impacto sobre prática clínica, protocolos assistenciais, políticas de saúde e formação médica. A produção científica está organizada em uma linha do tempo contínua entre 2012 e 2024, iniciando com base sólida em cardiologia hepática, interações coração-fígado e avaliação cardiovascular em transplantes; avançando, entre 2018 e 2020, para biomarcadores, estratificação de risco e manejo da insuficiência cardíaca; consolidando produção em cardiologia clínica entre 2021 e 2022; e alcançando, em 2023 e 2024, temas de inovação, terapias emergentes e novas abordagens cardiovasculares.

As principais linhas de pesquisa do ecossistema Silvestre Santé incluem cardiologia hepática, com estudos sobre cardiomiopatia cirrótica, alterações hemodinâmicas e



interações cardio-hepáticas; transplante e avaliação cardiovascular, com foco em avaliação pré-transplante, risco cardiovascular e desfechos clínicos; insuficiência cardíaca e biomarcadores, envolvendo peptídeos natriuréticos, estratificação de risco e medicina personalizada; e cardiologia clínica geral, com atualizações clínicas, revisões sistemáticas e aplicação prática no cuidado ao paciente. Essa trajetória demonstra capacidade concreta de transformar pesquisa em conhecimento aplicado, protocolos reais e melhoria da prática assistencial.

Além da produção científica, o Ecossistema Silvestre Santé possui histórico relevante de atuação social e educação em saúde no Acre. Entre 2017 e 2020, realizou palestras no interior do Estado, em municípios como Acrelândia, Capixaba, Sena Madureira e Xapuri, direcionadas a gestores públicos, profissionais e comunidade, promovendo a interiorização do conhecimento em saúde cardiovascular. Durante a crise sanitária da COVID-19, entre 2020 e 2022, desenvolveu programa de atendimento à população e teve atuação estratégica na presidência do Comitê de Enfrentamento à COVID-19, contribuindo em contexto de elevada mortalidade e apoio à tomada de decisão em saúde pública.

A partir de 2023, o Ecossistema ampliou sua atuação em educação médica e prevenção comunitária, com destaque para o Simpósio de Emergências Clínicas, voltado à capacitação de médicos, e para programas como Saúde em Movimento, Drive-Thru da Hipertensão, Saúde na Estrada e Aperta o Peito, este último com aproximadamente 1.000 pessoas treinadas presencialmente e alcance estimado de 300.000 pessoas nas redes sociais. Em 2025, o Ecossistema avançou em ações de especialização e educação médica continuada, incluindo simpósios e palestras sobre obesidade, emergências cardiológicas, doenças do colesterol, diagnóstico de doenças do coração e doença do sono, com foco em profissionais de saúde, médicos das UPA's e das UBS's.

Essa trajetória evidencia que o proponente e seu ecossistema institucional não atuam apenas na prestação de serviços assistenciais, mas possuem experiência concreta na combinação entre assistência, prevenção, educação, pesquisa e contribuição para políticas públicas. O próprio histórico de ações sociais do Ecossistema Silvestre Santé sintetiza uma atuação contínua entre 2020 e 2025, com mais de 10 programas estruturados e impacto direto sobre população geral, profissionais de saúde, gestores públicos e trabalhadores informais.

O portfólio de investimentos em saúde do Ecossistema Silvestre Santé reforça essa maturidade institucional ao apresentar projetos estruturados, escaláveis e prontos para captação de recursos, organizados em três frentes: prevenção, assistência e formação/capacitação. Entre os projetos em estruturação estão o Coração do



Futuro, voltado ao diagnóstico precoce de 5.000 crianças em escolas públicas com uso de inteligência artificial; o Coração Grande, direcionado a 1.000 pacientes do SUS em situação de vulnerabilidade; o Vida em Cheia, voltado a 3.000 pessoas em áreas atingidas por enchentes, combinando prevenção e pesquisa aplicada; o Centro de Habilidades, com formação prática de 288 profissionais por ano; e o Simpósio Clínicas Médicas Silvestre Santé 360, com previsão de 300 participantes do Brasil, Peru e Bolívia.

No contexto do Projeto Amazônia Sem Fronteiras, essa capacidade institucional representa um diferencial competitivo relevante. O ecossistema Silvestre Santé reúne capacidade assistencial instalada, histórico de execução social, produção científica indexada, experiência em educação médica, articulação com temas de saúde pública, carteira de projetos estruturados e vocação para inovação aplicada. Esses elementos reduzem potenciais riscos e demonstram que a proposta será executada por uma instituição com base técnica, presença territorial e capacidade de converter investimento em resultados mensuráveis.

A capacidade institucional do proponente se sustenta em três dimensões complementares: base científica consolidada, capacidade assistencial instalada e histórico de atuação social do ecossistema Silvestre Santé em saúde. Essa combinação confere ao iSanté condições técnicas, operacionais e estratégicas para executar projetos complexos, de longa duração e com alto grau de responsabilidade social, como o Projeto Amazônia Sem Fronteiras; reduzindo riscos de execução, pois combina infraestrutura assistencial disponível, equipe técnica, produção científica, experiência em ações sociais e articulação acadêmica.

O projeto, portanto, não parte de uma promessa abstrata, mas de uma base operacional existente, preparada para converter recursos financeiros em entregas assistenciais, ambientais, científicas e de governança com evidências documentais.

Assim, o iSanté se apresenta como proponente tecnicamente qualificado para liderar uma iniciativa de saúde humanitária, energia limpa e proteção social na Amazônia, apoiado por um ecossistema institucional que já demonstrou competência para integrar ciência, assistência, prevenção, formação e impacto social. A execução do projeto se beneficiará dessa base consolidada, permitindo transformar a infraestrutura energética proposta em sustentabilidade assistencial, produção de evidências, formação humanizada e ampliação do acesso à saúde para migrantes e refugiados em situação de vulnerabilidade no Acre.



5. DIAGNÓSTICO TERRITORIAL, MIGRATÓRIO, SANITÁRIO E ENERGÉTICO

5.1. Diagnóstico territorial e migratório

Entre 2015 e 2026, o Estado do Acre consolidou-se como um corredor migratório estratégico da Amazônia brasileira, com papel relevante na entrada, circulação, permanência e reorganização de migrantes e refugiados em território nacional. Segundo dados do Observatório da Segurança Pública do Acre, excluídos os registros de nacionalidade brasileira, foram contabilizadas 358.439 entradas de migrantes estrangeiros, 317.130 saídas e um saldo migratório positivo de 41.309 pessoas no período analisado, evidenciando que o Acre não se configura apenas como território de passagem, mas também como espaço de permanência, acolhimento e demanda por serviços públicos essenciais.

A série histórica demonstra a predominância de fluxos vinculados à dinâmica transfronteiriça com Peru e Bolívia, países que respondem pelos maiores volumes absolutos de entrada, com 161.202 e 136.663 registros, respectivamente. Esse dado confirma a centralidade geográfica do Acre na Amazônia Sul-Occidental e sua função como território de conexão humana, econômica e social entre Brasil, Peru e Bolívia. Ao mesmo tempo, os dados revelam a presença expressiva de migrantes oriundos da Venezuela, Haiti, Colômbia, Senegal e Equador, compondo um perfil migratório diverso, multicultural e marcado por diferentes graus de vulnerabilidade social, econômica, sanitária e documental.

A análise dos saldos migratórios reforça a dimensão humanitária do fenômeno. Venezuela, Haiti e Senegal apresentam saldos positivos expressivos, respectivamente 15.817, 10.194 e 3.584 pessoas, indicando maior probabilidade de permanência relativa no território acreano e, conseqüentemente, maior necessidade de respostas assistenciais contínuas, estruturadas e interculturais. Esses grupos, somados aos fluxos permanentes de peruanos e bolivianos, ampliam a pressão sobre a rede local de saúde, assistência social, acolhimento, vigilância epidemiológica e regulação de serviços especializados.

Esse cenário impõe desafios específicos ao sistema de saúde no Acre, especialmente no que se refere à triagem clínica, ao acesso a consultas especializadas, à realização de exames diagnósticos, à continuidade terapêutica, ao acompanhamento de doenças crônicas, à atenção materno-infantil, à saúde mental, à vigilância epidemiológica e ao cuidado de grupos mais vulneráveis, como mulheres, crianças, gestantes, idosos, pessoas com deficiência, pessoas sem documentação regular e indivíduos em situação de insegurança alimentar ou social. As barreiras linguísticas, culturais e institucionais também dificultam o acesso oportuno aos serviços, ampliando riscos de agravamento clínico, subnotificação de agravos e descontinuidade do cuidado.



A posição territorial do Acre, somada às limitações próprias do contexto amazônico, como distâncias geográficas, oferta restrita de especialidades, concentração de serviços em Rio Branco e pressão recorrente sobre o Sistema Único de Saúde, evidencia a necessidade de soluções complementares, qualificadas e sustentáveis. Nesse contexto, o Projeto Amazônia Sem Fronteiras propõe uma resposta integrada de saúde humanitária, energia limpa, pesquisa aplicada, formação profissional e governança ESG, estruturada para transformar eficiência energética em assistência médica gratuita, mensurável e sustentável para migrantes e refugiados em situação de vulnerabilidade no Estado do Acre.

5.2. Diagnóstico sanitário e lacunas assistenciais

A população migrante e refugiada tende a acessar os serviços de saúde em condição tardia, quando sintomas já se agravaram ou quando há necessidade de exames, avaliação especializada ou atendimento de urgência. A ausência de acompanhamento regular e as barreiras de comunicação dificultam rastreamento, continuidade do cuidado e prevenção de complicações, especialmente em doenças crônicas, condições cardiovasculares, gestação, saúde da criança, doenças infecciosas e saúde mental.

O projeto atuará de forma complementar ao SUS, ampliando acesso gratuito a consultas, exames e atendimentos de suporte, com foco em resolutividade clínica, acolhimento intercultural e produção de dados epidemiológicos que possam subsidiar planejamento público e ações de saúde migratória no território.

5.3. Diagnóstico energético e justificativa de infraestrutura crítica

A infraestrutura energética proposta responde a uma fragilidade recorrente em serviços essenciais: o peso dos custos de energia no orçamento operacional hospitalar e a necessidade de maior previsibilidade financeira. O anexo técnico informa fatura mensal de referência de R\$ 41.891,89, consumo de 5.850 kWh no horário de ponta, 54.000 kWh fora ponta e demanda contratada de 160 kW. A solução proposta combina geração solar fotovoltaica em operação zero grid e sistema BESS para deslocamento de consumo do horário de ponta, resultando em economia mensal estimada de R\$ 28.075,00 e economia anual estimada de R\$336.900,00.

A energia limpa passa, assim, a funcionar como mecanismo permanente de financiamento social. A economia gerada poderá ser redirecionada para consultas, exames, insumos, manutenção assistencial, acolhimento e continuidade do cuidado a migrantes e refugiados.

6. LINHA DE BASE

A linha de base preliminar do Projeto Amazônia Sem Fronteiras foi organizada por dimensões estratégicas para apresentar, de forma objetiva, o contexto que justifica



a intervenção e os principais elementos que irão orientar sua execução, monitoramento e avaliação.

A seguir estão reunidas as evidências iniciais sobre migração, saúde, energia, capacidade institucional, beneficiários e proteção; indicando as fontes de informação e as implicações diretas para o desenho da proposta. Por se tratar de linha de base preliminar, os dados irão ser complementados na etapa de validação participativa com parceiros institucionais, profissionais da rede pública, assistência social, estudantes e beneficiários migrantes.

Dimensão	Linha de base	Indicador	Fonte	Implicação Projeto
Migração	O projeto identifica o Acre como território de fronteira e corredor migratório internacional; por meio da entrada de 358.439 migrantes entre 2015 e 2026. Saldo migratório positivo de 41.309 pessoas	Entradas de estrangeiros no Acre	Observatório da Segurança Pública do Acre; estimativa populacional IBGE 2025.	A demanda por acolhimento e atenção à saúde não é episódica, mas contínua. Isso justifica a estruturação de uma resposta permanente, intercultural e territorialmente adequada, voltada a migrantes e refugiados em trânsito ou permanência no Estado.
Saúde	O projeto descreve barreiras de acesso, vulnerabilidade e pressão sobre o SUS.	Acesso de migrantes e refugiados a consultas, exames, diagnóstico e acompanhamento especializado	SESACRE; SEMSA Rio Branco; Sistema de Regulação; e-SUS; CNES.	Oferta organizada de consultas, exames, diagnóstico, acompanhamento clínico, atenção a doenças crônicas, cuidado materno-infantil, e suporte hospitalar de urgência. Atuação complementar ao SUS, contribuindo para reduzir barreiras de acesso e pressão sobre a rede pública.
Energia	Fatura mensal informada de R\$41.891,89, economia estimada de R\$28.075,00 por mês e R\$336.900,00 por ano.	Consumo energético hospitalar, custo da fatura e potencial de economia com energia limpa	Proposta técnica financeira da G2D Engenharia Ltda.	Criação de uma base de sustentabilidade financeira para o projeto. A economia gerada pela energia limpa será convertida em atendimentos gratuitos, tornando a infraestrutura energética um instrumento direto de financiamento social, resiliência hospitalar e impacto ESG mensurável.



Dimensão	Linha de base	Indicador	Fonte	Implicação Projeto
Capacidade institucional	Hospital com estrutura instalada, equipe multiprofissional e produção científica.	Estrutura assistencial, científica, acadêmica e administrativa disponível para execução do projeto	Cooperações técnicas estabelecidas com o Hospital Silvestre Santé e a UFAC.	A atuação integrada entre iSanté, Hospital Silvestre Santé e Universidade Federal do Acre demonstra capacidade técnica, assistencial, científica e acadêmica para execução do projeto. Essa dimensão reduz riscos para o financiador e fortalece a credibilidade da proposta,
Beneficiários	Previsão de 1.296 beneficiários diretos e cerca de 18.000 indiretos.	Migrantes e refugiados em situação de vulnerabilidade social, sanitária e humanitária	Observatório da Segurança Pública do Acre	Priorização de migrantes e refugiados em maior vulnerabilidade social, sanitária e humanitária, incluindo mulheres, crianças, gestantes, idosos, pessoas com doenças crônicas, pessoas com deficiência, migrantes sem documentação regular e pessoas com barreiras linguísticas.
Proteção	O projeto prevê acolhimento humanizado e prioridade para grupos vulneráveis.	Atendimento intercultural	Observatório da Segurança Pública do Acre	Acolhimento intercultural, mediação linguística, escuta qualificada, proteção de crianças e mulheres, consentimento informado, confidencialidade, adequação à LGPD, canal de denúncia e mecanismos de feedback dos beneficiários. E



7. TEORIA DE MUDANÇA

A teoria de mudança do Projeto Amazônia Sem Fronteiras parte da seguinte cadeia causal: se uma instituição de saúde amazônica em território de fronteira implanta infraestrutura de energia limpa, reduz custos operacionais e fortalece sua segurança energética, então parte dessa economia pode ser convertida de forma recorrente em assistência médica gratuita para migrantes e refugiados. Se essa assistência for executada por meio de protocolo humanitário, intercultural, monitorado e integrado à pesquisa aplicada, então haverá ampliação do acesso à saúde especializada, geração de evidências epidemiológicas, fortalecimento da formação médica humanizada e consolidação de um modelo ESG replicável para territórios amazônicos, conforme detalhamento a seguir:

Nível	Descrição
Problema central	Migrantes e refugiados em trânsito ou permanência no Acre enfrentam barreiras sociais, sanitárias, linguísticas, culturais, documentais e econômicas para acessar cuidados de saúde, especialmente consultas especializadas, exames diagnósticos, acompanhamento clínico e continuidade terapêutica.
Linha de base	O Acre apresenta fluxo migratório internacional expressivo, com 358.439 entradas de estrangeiros entre 2015 e 2026 e saldo migratório positivo de 41.309 pessoas, evidenciando pressão territorial e sanitária sobre a rede de serviços em um estado amazônico de baixa densidade populacional e oferta limitada de especialidades.
Escuta ativa - Validação	Antes da elaboração dos protocolos assistenciais, o projeto realizará escuta comunitária com migrantes e refugiados, profissionais do SUS, equipes da assistência social, estudantes da área da saúde e demais atores envolvidos no acolhimento territorial. Essa etapa permitirá confirmar se as propostas de fluxo, triagem, acolhimento, encaminhamento, mediação intercultural e acompanhamento clínico respondem às barreiras reais de acesso vivenciadas pela população migrante no Acre.
Insumos	Sistema solar fotovoltaico com BESS, estrutura hospitalar instalada, equipe multiprofissional, parceria com a UFAC, capacidade científica do iSanté, recursos financeiros, protocolos assistenciais, sistema de monitoramento ESG e articulação com a rede pública e social
Atividades	Implantação da infraestrutura energética sustentável; realização da validação participativa; construção dos protocolos de acolhimento humanitário e intercultural; oferta de consultas, exames e atendimentos; formação de estudantes; produção de dados epidemiológicos; monitoramento ESG; prestação de contas e avaliação de impacto.
Produtos	Sistema energético implantado, protocolos de atendimento, serviços gratuitos realizados, dados epidemiológicos produzidos, estudantes capacitados e relatórios de impacto publicados.
Resultados de curto e médio prazo	Redução de custos energéticos, ampliação do acesso gratuito à saúde, fortalecimento da capacidade diagnóstica, atendimento intercultural e geração de evidências sobre saúde migratória.
Impacto de longo prazo	Modelo amazônico replicável de saúde humanitária climaticamente resiliente, com energia limpa convertida em dignidade, proteção social e desenvolvimento sustentável.



8. OBJETIVOS

8.1 Objetivo geral

Promover acesso gratuito, humanizado e sustentável à assistência médica especializada para migrantes e refugiados em situação de vulnerabilidade no Acre, por meio de um modelo ESG que converte economia gerada por energia limpa em atendimento em saúde, produção científica, formação humanitária e fortalecimento da resiliência social na Amazônia brasileira.

8.2 Objetivos específicos

- Implantar infraestrutura de energia solar fotovoltaica com sistema de armazenamento energético, fortalecendo a eficiência e a segurança energética hospitalar.
- Converter a economia operacional gerada pela energia limpa em consultas, exames e atendimentos gratuitos para migrantes e refugiados vulneráveis.
- Estruturar protocolo de acolhimento humanitário e intercultural, com prioridade para mulheres, crianças, gestantes, idosos, pessoas com deficiência e pessoas em maior risco social.
- Ampliar o acesso à saúde especializada e diagnóstica, atuando de forma complementar ao SUS e contribuindo para redução da demanda reprimida.
- Produzir dados epidemiológicos e evidências científicas sobre saúde migratória na Amazônia.
- Fortalecer a formação prática humanizada de estudantes da área da saúde, integrando ensino, serviço e pesquisa aplicada.
- Implantar sistema de governança ESG com indicadores sociais, ambientais, assistenciais, financeiros e científicos auditáveis.
- Consolidar modelo replicável de saúde humanitária climaticamente resiliente para territórios amazônicos e fronteiriços.

9. PÚBLICO-ALVO E CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE E PRIORIZAÇÃO

O público-alvo direto do Projeto Amazônia Sem Fronteiras será composto por migrantes, refugiados, solicitantes de refúgio, apátridas e pessoas em mobilidade internacional residentes ou em trânsito no Estado do Acre, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade social, sanitária, econômica, linguística, documental ou territorial.

A proposta priorizará grupos com maior risco de desassistência, agravamento clínico e exclusão dos serviços de saúde, incluindo mulheres, crianças, adolescentes, gestantes, idosos, pessoas com deficiência, pessoas com doenças



crônicas, pessoas em situação de insegurança alimentar, migrantes sem rede de apoio familiar, pessoas com barreiras linguísticas relevantes e indivíduos com dificuldade de acesso regular à rede pública de saúde.

A elegibilidade para atendimento será orientada por critérios objetivos, transparentes e não discriminatórios, assegurando que a priorização dos atendimentos considere a condição de vulnerabilidade e a necessidade clínica, e não apenas a nacionalidade, situação documental ou ordem de chegada. A ausência de documentação civil ou migratória não impedirá o acolhimento inicial, a triagem socioassistencial nem a avaliação clínica, devendo ser adotados mecanismos alternativos de identificação provisória, preservando a dignidade, a confidencialidade e o direito ao cuidado em saúde.

9.1. Critérios de Elegibilidade

Serão elegíveis ao Projeto Amazônia Sem Fronteiras migrantes, refugiados, solicitantes de refúgio, apátridas e pessoas em mobilidade internacional residentes ou em trânsito no Acre, especialmente em situação de vulnerabilidade social, sanitária, econômica, linguística ou documental. A identificação poderá ocorrer por documento disponível ou, no caso de pessoas indocumentadas, por registro provisório interno, sem prejuízo ao acolhimento, à triagem socioassistencial e à avaliação clínica. A elegibilidade também poderá ser confirmada por encaminhamento da rede parceira, incluindo SUS, assistência social, unidades de acolhimento e organizações humanitárias, conforme descrito a seguir:

Critério	Descrição operacional
Condição migratória	Ser migrante, refugiado, solicitante de refúgio, apátrida ou pessoa em mobilidade internacional residente ou em trânsito no Acre. Quando houver documentação comprobatória, ela será registrada; quando não houver, será admitida autodeclaração qualificada, acompanhada de triagem social.
Identificação pessoal	Apresentação de documento de identificação, protocolo migratório, passaporte, Registro Nacional Migratório, CPF, cartão SUS ou outro documento disponível. Para pessoas indocumentadas, será criado registro provisório interno, com dados mínimos de identificação, país de origem, idioma, contato e referência territorial ou institucional, quando possível.
Vulnerabilidade social	Situação de insegurança alimentar, ausência de moradia adequada, desemprego, baixa renda, ausência de rede familiar, dificuldade de comunicação, exposição a violência, situação de rua, acolhimento institucional ou encaminhamento por rede socioassistencial.
Vulnerabilidade sanitária	Presença de sintomas, doenças crônicas, gestação, necessidade de acompanhamento clínico, demanda por exames, histórico de descontinuidade terapêutica, suspeita de agravos transmissíveis, sofrimento psíquico ou necessidade de atendimento especializado.
Residência ou trânsito no Acre	Permanência temporária, residência, circulação ou passagem pelo Estado do Acre, especialmente em Rio Branco e municípios vinculados aos fluxos migratórios de fronteira.
Encaminhamento pela rede parceira	Encaminhamento por serviços do SUS, assistência social, organizações humanitárias, instituições religiosas, universidades, abrigos, CRAS, CREAS, unidades de acolhimento ou demais parceiros territoriais. O encaminhamento será critério facilitador, mas não exclusivo.



9.2. Critérios de Priorização

Quando a demanda superar a capacidade operacional disponível, o projeto adotará critérios de priorização baseados em risco social, risco clínico e necessidade de proteção. A priorização será registrada em formulário próprio, garantindo rastreabilidade, transparência e accountability, distribuída nos seguintes níveis de priorização de atendimento:

Nível de prioridade	Perfil do beneficiário	Encaminhamento previsto
Prioridade alta	Gestantes, crianças, idosos, pessoas com deficiência, pessoas com sintomas agudos, doenças crônicas descompensadas, suspeita de agravos transmissíveis, sofrimento psíquico intenso, vítimas de violência, pessoas em situação de rua ou insegurança alimentar grave.	Atendimento clínico prioritário, realização de exames conforme necessidade, suporte ambulatorial ou hospitalar e articulação imediata com SUS, assistência social ou rede de proteção.
Prioridade média	Migrantes com doenças crônicas estáveis, necessidade de consulta especializada, exames diagnósticos pendentes, barreiras linguísticas relevantes, descontinuidade terapêutica ou ausência de acompanhamento regular.	Agendamento assistencial, consulta clínica ou especializada, exames complementares, orientação em saúde e vinculação à rede parceira.
Prioridade regular	Migrantes sem urgência clínica imediata, mas com necessidade de avaliação preventiva, orientação, cadastro, triagem ou encaminhamento para serviços territoriais.	Acolhimento, cadastro, orientação, educação em saúde, triagem e agendamento conforme disponibilidade do projeto.

9.3. Fluxo de Acesso e Encaminhamento

O acesso aos serviços do projeto ocorrerá por demanda espontânea qualificada, busca ativa ou encaminhamento realizado pela rede parceira, distribuído nas seguintes etapas:

Etapas	Procedimento
1. Acolhimento inicial	Recepção humanizada, escuta breve, identificação do idioma, verificação de necessidade imediata e orientação sobre o funcionamento do projeto.
2. Identificação e cadastro	Registro de documento disponível ou criação de identificação provisória para pessoas indocumentadas, com garantia de confidencialidade e proteção de dados.
3. Triagem socioassistencial	Levantamento de condições sociais, situação de moradia, alimentação, renda, documentação, rede de apoio, barreiras linguísticas e riscos de proteção.
4. Avaliação clínica inicial	Verificação de queixa principal, sinais de alerta, doenças prévias, uso de medicamentos, gestação, condição crônica ou necessidade de atendimento especializado.
5. Classificação de prioridade	Aplicação dos critérios de priorização com base em risco clínico, vulnerabilidade social e necessidade de proteção.
6. Encaminhamento assistencial	Direcionamento para consulta, exame, atendimento ambulatorial, suporte hospitalar ou orientação em saúde, conforme protocolo do projeto.
7. Articulação com rede parceira	Encaminhamento para SUS, assistência social, rede de proteção, abrigos, organizações humanitárias, documentação ou outros serviços, quando necessário.
8. Acompanhamento e registro	Registro do atendimento, conduta, encaminhamento, retorno previsto e indicadores de monitoramento, preservando sigilo e conformidade com a LGPD.



9.4. Salvaguardas de Equidade e Transparência

A aplicação dos critérios de elegibilidade e priorização irá observar os princípios de dignidade humana, não discriminação, confidencialidade, equidade, transparência e proteção de populações vulneráveis. Nenhuma pessoa será excluída do acolhimento inicial por ausência de documentação, nacionalidade, idioma, raça, religião, gênero, orientação sexual, condição econômica ou situação migratória.

O projeto irá manter registros padronizados dos atendimentos, justificativas de priorização, encaminhamentos realizados e retornos previstos, de modo a permitir monitoramento, prestação de contas, avaliação de impacto e correção de eventuais distorções no acesso. Também serão previstos mecanismos de escuta e feedback dos beneficiários, assegurando que a população atendida possa informar barreiras, dificuldades, insatisfações ou riscos percebidos durante a execução da proposta.

9.5. Beneficiários Diretos

Ano	Beneficiários diretos	Leitura estratégica
Ano 1	432	Implantação energética, validação participativa da Teoria da Mudança, estruturação assistencial, elaboração dos protocolos, capacitação das equipes e início gradual dos atendimentos. O Ano 1 funcionará como fase de implantação e ramp-up operacional, com expansão progressiva da capacidade de acolhimento, consultas, exames e encaminhamentos.
Ano 2	864	Maturidade operacional do modelo, ampliação dos atendimentos, produção de evidências, integração ensino-serviço, monitoramento ESG, consolidação dos fluxos assistenciais, avaliação final, disseminação de resultados, sustentabilidade e replicabilidade do modelo.
Total	1.296	Estimativa de beneficiários diretos ao longo de 24 meses, considerando crescimento progressivo da capacidade operacional, critérios de elegibilidade, priorização clínica e social e disponibilidade assistencial prevista.

10. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO

A metodologia do Projeto Amazônia Sem Fronteiras adota abordagem integrada, participativa e orientada por evidências, articulando saúde humanitária, energia limpa, formação profissional, pesquisa aplicada, proteção social e governança ESG. O desenho metodológico reconhece que a vulnerabilidade de migrantes e refugiados no Acre vai além do acesso pontual a consultas: envolve barreiras sociais, sanitárias, linguísticas, culturais, documentais, econômicas e territoriais que dificultam a continuidade do cuidado.



A execução será organizada em eixos complementares, com fluxos definidos, indicadores mensuráveis, critérios objetivos de elegibilidade e priorização, salvaguardas para os beneficiários e sistema de monitoramento capaz de demonstrar resultados sociais, ambientais, assistenciais, científicos e institucionais.

10.1. Validação Participativa da Teoria da Mudança

Antes da elaboração definitiva dos protocolos assistenciais, o projeto realizará uma etapa de validação participativa da Teoria da Mudança, envolvendo parceiros institucionais, migrantes e refugiados, profissionais do SUS, equipes da assistência social, estudantes da área da saúde, organizações humanitárias e demais atores territoriais.

Essa etapa terá como objetivo verificar se as soluções propostas pelo projeto respondem às barreiras reais de acesso enfrentadas pela população migrante no Acre, especialmente quanto ao acolhimento, triagem, comunicação, encaminhamento, acesso a consultas, exames, retorno clínico, acompanhamento terapêutico e proteção de grupos vulneráveis.

A validação poderá ser realizada por meio de escutas comunitárias, entrevistas orientadas, reuniões técnicas, grupos focais e oficinas com parceiros. Os resultados dessa escuta subsidiarão a construção dos protocolos de atendimento, dos critérios de priorização, dos instrumentos de registro, dos materiais de orientação e dos mecanismos de encaminhamento pela rede parceira.

10.2. Eixo 1 - Implantação da Infraestrutura Energética Sustentável

O primeiro eixo será voltado à implantação do sistema solar fotovoltaico de 404,46 kWp, associado ao sistema de armazenamento energético por baterias, com operação orientada à eficiência, segurança energética e redução dos custos operacionais do Hospital Silvestre Santé.

A infraestrutura energética será implantada em etapas: aquisição dos equipamentos, instalação dos módulos fotovoltaicos, implantação dos inversores, instalação do sistema de armazenamento, integração ao sistema elétrico hospitalar, homologação técnica, testes operacionais e ativação do monitoramento energético.

A economia operacional estimada será convertida em financiamento social para a oferta gratuita de atendimentos em saúde a migrantes e refugiados. Dessa forma, a energia limpa deixará de ser apenas uma solução ambiental e passará a funcionar como mecanismo permanente de sustentabilidade financeira da assistência humanitária.



Serão monitorados indicadores como energia gerada, economia mensal e anual, redução percentual da fatura, disponibilidade operacional do sistema, desempenho do BESS, redução estimada de emissões e valor financeiro convertido em serviços de saúde.

10.3. Eixo 2 - Estruturação Assistencial e Protocolos de Atendimento Humanitário

Após a validação participativa, serão elaborados os protocolos assistenciais do projeto, com definição dos fluxos de acolhimento, elegibilidade, triagem socioassistencial, avaliação clínica, classificação de prioridade, encaminhamento interno, encaminhamento externo e acompanhamento dos beneficiários.

Os protocolos irão contemplar critérios objetivos de elegibilidade e priorização, assegurando transparência, equidade e accountability. A ausência de documentação não impedirá o acolhimento inicial, a triagem nem a avaliação clínica, sendo admitido registro provisório interno para pessoas indocumentadas, com preservação da confidencialidade, dignidade e proteção de dados.

A estruturação assistencial irá diferenciar claramente:

Categoria	Finalidade
Pessoas únicas atendidas	Número de beneficiários individuais cadastrados e acompanhados pelo projeto.
Atendimentos totais	Soma de todos os contatos assistenciais realizados, incluindo consultas, exames, retornos, orientações e urgências.
Consultas médicas	Atendimentos clínicos gerais ou especializados realizados por profissional médico.
Exames laboratoriais	Testes e análises clínicas realizados para apoio diagnóstico.
Exames de imagem	Ultrassonografia, raio X, tomografia e demais exames disponíveis no escopo do projeto.
Retornos clínicos	Reavaliações programadas após consulta, exame ou conduta terapêutica.
Urgências e suporte hospitalar	Atendimentos de maior gravidade, conforme capacidade operacional e critérios clínicos.
Acompanhamentos longitudinais	Seguimento de beneficiários com doenças crônicas, gestação, condições de risco ou necessidade de continuidade terapêutica.

Essa separação permitirá mensuração precisa da produção assistencial, evitando confusão entre número de beneficiários e número de procedimentos realizados.



10.4. Eixo 3 - Atendimento Humanitário em Saúde

O atendimento humanitário será realizado prioritariamente nas dependências do Hospital Silvestre Santé, com apoio do iSanté e articulação com a rede pública e socioassistencial. O fluxo assistencial irá seguir uma sequência padronizada: acolhimento inicial, identificação ou registro provisório, triagem socioassistencial, avaliação clínica, classificação de prioridade, consulta, exames, conduta, retorno e encaminhamento quando necessário.

A carteira de serviços poderá incluir consultas clínicas gerais, consultas especializadas, exames laboratoriais, exames de imagem, atendimento ambulatorial, suporte hospitalar de urgência, orientação em saúde e acompanhamento de casos prioritários.

A priorização considerará risco clínico e vulnerabilidade social, com atenção especial a mulheres, crianças, adolescentes, gestantes, idosos, pessoas com deficiência, pessoas com doenças crônicas, pessoas em insegurança alimentar, migrantes sem documentação regular, pessoas com barreiras linguísticas e indivíduos encaminhados por rede parceira.

O projeto irá atuar de forma complementar ao SUS, contribuindo para reduzir barreiras de acesso, apoiar a triagem qualificada, ampliar a capacidade diagnóstica e produzir dados úteis ao planejamento de políticas públicas voltadas à saúde migratória na Amazônia.

10.5. Eixo 4 - Formação Profissional, Ensino e Integração Serviço-Comunidade

O projeto implantará uma trilha formativa vinculada à prática assistencial, à sustentabilidade hospitalar e à governança ESG aplicada à saúde. Essa formação será voltada a estudantes da área da saúde, profissionais envolvidos no projeto, equipe multiprofissional, jovens, colaboradores institucionais e, quando viável, migrantes interessados em ações educativas e de capacitação básica.

A formação irá prever metas anuais de participantes, carga horária, conteúdo programático e certificação simples de participação. Recomenda-se organizar a formação em trilhas temáticas:



Trilha formativa	Conteúdos estabelecidos	Público prioritário
Saúde humanitária e atendimento intercultural	Acolhimento, comunicação com migrantes, barreiras culturais, abordagem sensível a trauma, ética e equidade.	Estudantes, equipe de saúde e rede parceira.
Saúde migratória e vigilância epidemiológica	Perfil dos fluxos migratórios, registro de dados, agravos prevalentes, continuidade do cuidado e encaminhamentos.	Estudantes, pesquisadores e profissionais de saúde.
Energia limpa e sustentabilidade hospitalar	Energia solar, eficiência energética, uso racional de recursos, segurança energética e sustentabilidade em serviços de saúde.	Estudantes, colaboradores e jovens participantes.
ESG aplicado à saúde	Indicadores ESG, impacto social, governança, transparência, prestação de contas e relatórios de impacto.	Equipe gestora, estudantes e parceiros institucionais.
Proteção, salvaguardas e direitos	Proteção infantil, gênero, confidencialidade, LGPD, consentimento informado, canal de denúncia e não discriminação.	Equipe do projeto, parceiros e estudantes.

Como meta preliminar, será realizada a capacitação de participantes ao longo dos 24 meses, com carga horária mínima organizada por módulos e emissão de declaração ou certificado simples. A meta final irá ser ajustada conforme capacidade operacional, cronograma acadêmico da UFAC e disponibilidade dos parceiros.

10.6. Eixo 5 - Pesquisa Aplicada e Produção de Evidências

O componente de pesquisa aplicada será desenvolvido em cooperação com a Universidade Federal do Acre e terá como finalidade produzir evidências sobre saúde migratória, acesso a serviços, perfil epidemiológico, barreiras de cuidado, resolutividade assistencial, impacto social e sustentabilidade do modelo ESG proposto.

A produção de evidências irá respeitar critérios éticos, especialmente quando envolver dados sensíveis de saúde ou participação direta de beneficiários. Pesquisas com seres humanos irão observar submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa, consentimento livre e esclarecido, proteção de dados pessoais, confidencialidade e uso responsável das informações.

Os produtos esperados incluem relatórios epidemiológicos, boletins técnicos, estudos de caso, resumos científicos, artigos, apresentações em eventos e sistematização metodológica do modelo. Essa produção fortalecerá a capacidade do projeto de gerar conhecimento aplicado para o Acre, para a Amazônia e para outros territórios de fronteira.



10.7. Eixo 6 - Salvaguardas, Proteção e Accountability

O projeto irá formalizar uma Política de Salvaguardas e Proteção, contemplando proteção infantil, proteção de mulheres e pessoas em situação de violência, abordagem sensível a gênero, não discriminação, confidencialidade, LGPD, consentimento informado, escuta qualificada, canal de denúncia e mecanismos de feedback dos beneficiários.

Essa política irá orientar toda a equipe envolvida, incluindo profissionais de saúde, estudantes, pesquisadores, equipe administrativa, mediadores interculturais e parceiros institucionais. A política também irá prever procedimentos para identificação e encaminhamento de situações de risco, como violência, exploração, negligência, sofrimento psíquico grave, insegurança alimentar extrema, abandono, situação de rua e outras violações de direitos.

Os beneficiários irão receber informações claras sobre o funcionamento do projeto, os serviços disponíveis, os limites da assistência, o uso dos dados, a confidencialidade das informações e os canais disponíveis para dúvidas, reclamações, denúncias ou sugestões. Essa dimensão é essencial para assegurar transparência, equidade e accountability perante financiadores, parceiros e população atendida.

10.8. Eixo 7 - Governança ESG, Monitoramento e Avaliação de Impacto

A governança do projeto será estruturada com base em indicadores sociais, assistenciais, ambientais, científicos, financeiros e institucionais. Será instituído comitê de governança, responsável por acompanhar a execução física e financeira, analisar riscos, validar relatórios, monitorar resultados e apoiar a tomada de decisão.

O sistema de monitoramento irá acompanhar, no mínimo, os seguintes grupos de indicadores:

Grupo de indicadores	Exemplos
Assistenciais	Pessoas únicas atendidas, atendimentos totais, consultas, exames, retornos, urgências, acompanhamentos e encaminhamentos.
Sociais e de proteção	Perfil dos beneficiários, grupos prioritários atendidos, barreiras identificadas, encaminhamentos socioassistenciais, demandas de proteção e feedback dos usuários.
Ambientais e energéticos	Energia gerada, economia financeira, redução da fatura, desempenho do BESS, emissões evitadas e valor convertido em assistência.



Grupo de indicadores	Exemplos
Acadêmicos e científicos	Estudantes capacitados, horas de formação, pesquisas desenvolvidas, relatórios produzidos, publicações e eventos científicos.
Governança e transparência	Execução financeira, relatórios ESG, reuniões do comitê, riscos monitorados, prestação de contas e medidas corretivas adotadas.

A avaliação irá ocorrer de forma contínua, com relatórios periódicos, análise de resultados, revisão dos protocolos e ajustes metodológicos sempre que os dados indicarem necessidade de melhoria. Ao final dos 24 meses, será elaborada avaliação de impacto e sistematização do modelo para fins de disseminação e replicabilidade.

10.9. Fluxo Metodológico Integrado

O projeto será executado em lógica progressiva e integrada. Inicialmente, será realizada a validação participativa da Teoria da Mudança, seguida da estruturação dos protocolos, implantação da infraestrutura energética, capacitação das equipes, início gradual dos atendimentos, monitoramento dos indicadores e produção de evidências. Com a maturidade operacional, o projeto avançará para consolidação do modelo, avaliação de impacto, disseminação dos resultados e planejamento de sustentabilidade.

Essa metodologia assegura que o projeto não seja apenas uma intervenção assistencial, mas uma plataforma integrada de transformação social, capaz de articular energia limpa, saúde humanitária, ciência aplicada, formação profissional, proteção de populações vulneráveis e governança ESG em um modelo replicável para territórios amazônicos e fronteiriços.



10.10. Estrutura Analítica do Projeto – EAP

A Estrutura Analítica do Projeto – EAP apresenta a decomposição do Projeto Amazônia Sem Fronteiras em eixos, pacotes de trabalho e entregas principais, permitindo visualizar a lógica de execução integrada entre infraestrutura energética, estruturação assistencial, atendimento humanitário, ensino e pesquisa, governança ESG, sustentabilidade, comunicação, replicabilidade e gerenciamento do projeto. Essa EAP é a referência para o plano orçamentário-financeiro, memória de cálculo, cronograma físico-financeiro, monitoramento das entregas e prestação de contas aos financiadores.



PROJETO AMAZÔNIA SEM FRONTEIRAS

Saúde Humanitária • Energia Limpa • Proteção • ESG



Estrutura Analítica do Projeto (EAP) alinhada à metodologia, matriz lógica, governança ESG e estratégia de sustentabilidade do Projeto Amazônia Sem Fronteiras.



11. SOLUÇÃO ENERGÉTICA SUSTENTÁVEL E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

A solução energética proposta consiste na implantação de sistema solar fotovoltaico associado a armazenamento por baterias, operando em regime zero grid, com priorização do autoconsumo e utilização do BESS para deslocamento de consumo no horário de ponta. O desenho técnico apresentado nos anexos indica potência fotovoltaica de 404,46 kWp, composta por 642 módulos bifaciais de 630 Wp, conversão AC por 4 inversores Huawei de 75 kW, totalizando 300 kW de potência inversora instalada, e sistema de armazenamento destinado à otimização do consumo no horário de maior custo.

Item técnico	Especificação	Observação estratégica
Potência fotovoltaica	404,46 kWp	Escala compatível com estratégia de redução expressiva de custo operacional hospitalar.
Módulos	642 módulos bifaciais de 630 Wp, tecnologia N-type	Datasheet Jinko 625-650 W indica módulos bifaciais dual glass, garantia de produto de 12 anos e garantia linear de potência de 30 anos.
Inversores	4 inversores Huawei SUN2000-75KTL-M1	Datasheet indica potência nominal de 75 kW, eficiência máxima de 98,6%, 10 MPPT, proteção IP66 e proteções elétricas integradas.
BESS	Sistema de armazenamento para deslocamento de consumo do horário de ponta	Anexo técnico informa 125 kW / 261 kWh, enquanto o datasheet Huawei LUNA2000-215-2S10 informa capacidade nominal de 215 kWh e PCS de 108 kW.
Operação	Zero grid, sem exportação de energia para rede	Estratégia voltada ao autoconsumo, redução de custo e previsibilidade energética.
Geração considerada	40.000 kWh/mês em premissa conservadora	O estudo mantém premissa conservadora para evitar superestimação de ganhos.
Economia estimada	R\$ 28.075,00/mês e R\$ 336.900,00/ano	Economia anual será convertida em assistência humanitária em saúde.
Payback simples	Aproximadamente 4,01 anos	O investimento praticamente se recupera ao final do quarto ano, com saldo positivo a partir do quinto ano.

12. PLANO ASSISTENCIAL HUMANITÁRIO E INTERCULTURAL

O atendimento humanitário do Projeto Amazônia Sem Fronteiras será realizado prioritariamente nas dependências do Hospital Silvestre Santé, com apoio operacional do iSanté, articulação com a Universidade Federal do Acre e integração com a rede pública e socioassistencial parceira. O plano assistencial será orientado



por princípios de dignidade humana, equidade, confidencialidade, segurança clínica, não discriminação, proteção de dados e respeito às diferenças linguísticas, culturais, religiosas, sociais e territoriais da população migrante e refugiada.

Considerando o perfil migratório identificado no Acre entre 2015 e 2026, com fluxos expressivos de migrantes oriundos do Peru, Bolívia, Venezuela, Haiti, Senegal, Colômbia e Equador, o projeto adotará um protocolo intercultural multilíngue, com materiais informativos e instrumentos de acolhimento em português e espanhol, além de francês e/ou creole haitiano quando aplicável, especialmente para atendimento de pessoas haitianas, senegalesas ou de outros grupos francófonos. Sempre que necessário, serão acionados mediadores culturais ou apoio de interpretação para qualificar a comunicação, reduzir barreiras de acesso, evitar falhas de compreensão clínica e fortalecer a adesão ao plano terapêutico.

O protocolo intercultural irá prever, no mínimo, identificação do idioma de preferência no acolhimento inicial, registro da necessidade de mediação linguística, explicação acessível sobre os serviços disponíveis, consentimento informado em linguagem compreensível, orientação sobre confidencialidade, registro de atendimentos com mediação cultural e encaminhamento qualificado à rede parceira quando houver necessidade de continuidade do cuidado, proteção social ou suporte institucional.

12.1. Diretrizes do Atendimento Intercultural Multilíngue

Diretriz	Descrição operacional	Evidências a serem apresentadas
Identificação linguística inicial	No acolhimento, a equipe irá identificar o idioma de preferência do beneficiário, sua capacidade de comunicação em português e eventual necessidade de intérprete ou mediador cultural.	Campo específico na ficha de acolhimento, registro do idioma e indicação de necessidade de mediação.
Materiais multilíngues	O projeto irá disponibilizar orientações básicas em português e espanhol, com versões em francês e/ou creole haitiano quando aplicável, abordando fluxo de atendimento, direitos, confidencialidade, consentimento, retorno e canais de comunicação.	Cartilhas, folders, formulários simplificados, placas informativas e termos de orientação multilíngues.
Mediação cultural	Quando houver barreira linguística, cultural ou dificuldade de compreensão do cuidado, será acionado mediador cultural, intérprete ou apoio qualificado da rede parceira.	Registro do acionamento, nome ou identificação do mediador, idioma utilizado e etapa do atendimento apoiada.



Diretriz	Descrição operacional	Evidências a serem apresentadas
Comunicação clínica segura	Informações sobre queixa principal, sintomas, uso de medicamentos, gestação, alergias, histórico de doenças e plano terapêutico irão ser confirmadas de forma compreensível, evitando erro assistencial por falha de comunicação. A equipe irá observar práticas culturais, religiosas, familiares e de gênero que possam influenciar o atendimento, sem comprometer a segurança clínica ou os direitos do beneficiário.	Prontuário, termo de consentimento, registro da orientação clínica e confirmação de compreensão pelo beneficiário.
Respeito cultural e religioso	Informações pessoais, migratórias e clínicas irão ser tratadas com sigilo, em conformidade com a LGPD e com os protocolos internos de proteção. Os beneficiários irão receber orientação sobre como apresentar dúvidas, reclamações, sugestões ou denúncias, inclusive quando houver barreiras linguísticas.	Registro de observações relevantes no prontuário ou ficha social, quando necessário.
Confidencialidade e proteção de dados		Termo de consentimento, registro seguro dos dados e controle de acesso às informações.
Canal de feedback e denúncia		Registro do canal de comunicação, formulário de feedback e relatório de manifestações recebidas.

12.2. Idiomas Prioritários e Estratégia de Comunicação

Idioma	Público relacionado	Aplicação no projeto
Português	Beneficiários com domínio do idioma, equipe técnica, documentos institucionais e registros oficiais.	Idioma-base dos atendimentos, prontuários, relatórios, protocolos e documentos administrativos.
Espanhol	Migrantes oriundos do Peru, Bolívia, Venezuela, Colômbia, Equador e demais países hispano-americanos.	Materiais de acolhimento, orientações de saúde, explicação de fluxos, consentimento simplificado e apoio à comunicação clínica.
Francês	Migrantes francófonos, especialmente quando houver demanda de pessoas do Senegal, Congo ou outros países africanos francófonos.	Apoio complementar em acolhimento, orientação sobre serviços e comunicação assistencial quando aplicável.
Creole haitiano	Migrantes haitianos, especialmente pessoas com baixa compreensão de português, espanhol ou francês.	Materiais básicos de orientação, apoio de mediação cultural e comunicação sobre consentimento, retorno e cuidado em saúde.
Outros idiomas	Beneficiários de nacionalidades com menor volume, mas possível alta vulnerabilidade, como pessoas oriundas da Ásia, África ou Oriente Médio.	Acionamento excepcional de rede parceira, ferramentas de apoio linguístico e mediação por organizações humanitárias quando disponível.



12.3. Mediador Cultural e Intérprete

O projeto contará com apoio de mediador cultural e/ou intérprete para situações em que a barreira linguística ou cultural possa comprometer o acolhimento, a segurança clínica, a compreensão do diagnóstico, a adesão ao tratamento, o consentimento informado ou o encaminhamento à rede parceira.

O mediador cultural irá atuar como ponte entre beneficiário, equipe de saúde e rede institucional, apoiando a comunicação e a compreensão mútua, sem substituir a responsabilidade técnica dos profissionais de saúde. Sua atuação irá respeitar sigilo, neutralidade, ética, proteção de dados e não interferência indevida na decisão clínica.

Elemento	Definição operacional
Forma de acionamento	O mediador será acionado pela equipe de acolhimento, triagem, assistência social, enfermagem ou equipe médica sempre que identificada barreira linguística, cultural ou dificuldade de compreensão do atendimento.
Momentos prioritários de atuação	Acolhimento inicial, triagem social e clínica, consentimento informado, consulta médica, explicação de exames, comunicação de conduta, orientação de retorno, encaminhamento para rede parceira e situações de proteção.
Carga horária	A carga horária mínima semanal para mediação intercultural, será ajustável conforme demanda assistencial. Como parâmetro inicial, pode-se prever disponibilidade de 20 horas semanais, presencial ou híbrida, com possibilidade de acionamento sob demanda em dias de atendimento do projeto.
Registro obrigatório	Todo atendimento com mediação irá registrar idioma utilizado, motivo do acionamento, etapa do atendimento, identificação do mediador, tempo aproximado de apoio e observações relevantes para continuidade do cuidado.
Confidencialidade	O mediador irá assinar termo de confidencialidade e receber orientação sobre LGPD, sigilo de dados de saúde, proteção de crianças e mulheres, não discriminação e conduta ética.



12.4. Fluxo Assistencial Humanitário e Intercultural

Etapa do fluxo		Descrição operacional	Evidência esperada
Acolhimento humanizado		Recepção digna, identificação do idioma, escuta inicial, orientação sobre o funcionamento do projeto, direitos, confidencialidade e serviços disponíveis. Quando necessário, acionamento de mediador cultural.	Ficha de acolhimento, registro de idioma, termo de consentimento, protocolo de atendimento e registro de mediação, quando houver.
Cadastro e identificação	e	Registro de documento disponível, como passaporte, protocolo migratório, Registro Nacional Migratório, CPF, Cartão SUS ou outro documento. Para pessoas indocumentadas, será criado registro provisório interno.	Ficha cadastral, registro provisório, cópia ou anotação do documento apresentado, quando houver, e controle de proteção de dados.
Triagem socioassistencial		Levantamento de vulnerabilidades sociais, situação documental, moradia, alimentação, renda, rede de apoio, barreiras linguísticas, riscos de proteção e necessidade de encaminhamento à rede parceira.	Formulário de triagem social, escala de vulnerabilidade, registro de encaminhamento e relatório socioassistencial.
Triagem clínica		Avaliação inicial de queixas, sintomas, doenças prévias, uso de medicamentos, gestação, sinais de alerta, risco clínico e necessidade de priorização assistencial.	Formulário de triagem clínica, classificação de prioridade, registro em prontuário e encaminhamento interno.
Consulta inicial	clínica	Avaliação médica, definição de hipótese diagnóstica, solicitação de exames, plano de cuidado, orientação terapêutica e definição de retorno ou encaminhamento especializado.	Prontuário, guia de conduta, plano terapêutico, solicitação de exames e registro de compreensão pelo beneficiário.
Exames laboratoriais e de imagem		Realização de exames conforme indicação clínica e capacidade do projeto, com explicação prévia do procedimento em linguagem acessível.	Laudos laboratoriais, laudos de imagem, registro de realização e vinculação ao prontuário.
Encaminhamento especializado		Encaminhamento para cardiologia, infectologia, neurologia, reumatologia, ginecologia, pediatria ou outra especialidade prevista, conforme necessidade clínica.	Agenda médica, relatório de encaminhamento, registro de contrarreferência e evolução clínica.
Atendimento ambulatorial ou suporte de urgência	ou de	Atendimento de maior gravidade ou necessidade imediata, respeitando a capacidade operacional do projeto e os protocolos de regulação e encaminhamento ao SUS quando necessário.	Registro hospitalar, ficha de atendimento, evolução clínica, conduta adotada e encaminhamento à rede pública, quando aplicável.
Acompanhamento terapêutico		Retorno programado, avaliação de exames, revisão do plano de cuidado, monitoramento de adesão, orientação de continuidade terapêutica e articulação com a rede pública ou socioassistencial.	Registro de retorno, evolução clínica, relatório de desfecho, encaminhamento externo e acompanhamento de casos prioritários.



12.5. Registro dos Atendimentos com Mediação Intercultural

Para assegurar rastreabilidade, qualidade assistencial e prestação de contas, o projeto irá manter registro específico dos atendimentos que exigirem apoio linguístico ou mediação cultural.

Campo mínimo de registro	Finalidade
Nome ou código do beneficiário	Vincular o atendimento ao prontuário sem exposição indevida de dados pessoais.
Nacionalidade e idioma preferencial	Monitorar perfil linguístico da demanda atendida.
Tipo de mediação acionada	Registrar se houve apoio presencial, remoto, por parceiro institucional ou material multilíngue.
Etapas do atendimento	Identificar em qual momento a mediação foi necessária: acolhimento, triagem, consulta, exames, retorno ou proteção.
Motivo do acionamento	Registrar barreira linguística, incompreensão do plano terapêutico, consentimento, encaminhamento ou situação de proteção.
Tempo aproximado de apoio	Apoiar planejamento de carga horária e dimensionamento da equipe.
Encaminhamento realizado	Garantir continuidade do cuidado e integração com a rede parceira.
Observações relevantes	Registrar aspectos que possam melhorar a qualidade do atendimento futuro, preservando sigilo.

12.6. Materiais Interculturais e Multilíngues

O projeto irá desenvolver materiais simples, objetivos e visualmente acessíveis, evitando linguagem excessivamente técnica. Os materiais irão estar disponíveis em formato impresso e, quando possível, digital.

Material	Idiomas recomendados	Conteúdo mínimo
Folder de apresentação do projeto	Português e espanhol, com versão em francês ou creole haitiano quando aplicável.	Quem pode ser atendido, serviços disponíveis, local, horário, documentos aceitos e canais de contato.
Orientação sobre consentimento e uso de dados	Português, espanhol e versões complementares conforme demanda.	Confidencialidade, LGPD, uso de dados, direito de recusa e proteção das informações.
Cartão de retorno	Português e espanhol.	Data, horário, local, profissional ou serviço, documentos a levar e orientação em caso de urgência.
Orientações básicas de saúde	Português e espanhol, com versões específicas conforme demanda.	Prevenção, uso de medicamentos, sinais de alerta, vacinação, gestação, doenças crônicas e retorno.
Canal de denúncia e feedback	Português, espanhol e versão complementar quando necessário.	Como registrar reclamação, denúncia, sugestão ou dificuldade de acesso.



12.7. Salvaguardas Assistenciais no Atendimento Intercultural

O atendimento intercultural irá estar integrado à política de salvaguardas do projeto, especialmente quando envolver crianças, adolescentes, mulheres, gestantes, pessoas com deficiência, vítimas de violência, pessoas em sofrimento psíquico, indivíduos indocumentados e pessoas sem rede de apoio.

A equipe irá observar sinais de risco social ou violação de direitos e, quando necessário, acionar a rede de proteção competente, incluindo assistência social, conselho tutelar, serviços do SUS, unidades de acolhimento, organizações humanitárias e demais instituições parceiras. Todas as condutas irão ser registradas com sigilo, proporcionalidade e respeito à autonomia do beneficiário.

O protocolo irá assegurar que a condição migratória, a ausência de documentação ou a barreira linguística não sejam utilizadas como impedimento para acolhimento, triagem ou avaliação clínica inicial. A priorização irá ser orientada por vulnerabilidade social, risco clínico e necessidade de proteção.

12.8. Indicadores do Plano Assistencial Intercultural

Indicador	Finalidade
Número de pessoas únicas atendidas por nacionalidade e idioma	Identificar perfil dos beneficiários e adequar materiais e mediação.
Número de atendimentos com mediação cultural ou linguística	Medir demanda por apoio intercultural.
Percentual de beneficiários com idioma registrado no acolhimento	Verificar qualidade do cadastro e aderência ao protocolo.
Quantidade de materiais multilíngues produzidos e distribuídos	Demonstrar acessibilidade da comunicação.
Número de encaminhamentos realizados à rede parceira	Medir integração com SUS, assistência social e proteção.
Número de retornos concluídos	Avaliar continuidade do cuidado.
Número de manifestações recebidas por canal de feedback	Monitorar accountability e barreiras percebidas pelos beneficiários.
Percentual de equipe capacitada em atendimento intercultural	Demonstrar preparo institucional para execução do plano.

O Plano Assistencial Humanitário e Intercultural do Projeto Amazônia Sem Fronteiras busca garantir que migrantes e refugiados sejam atendidos com segurança clínica, dignidade, acessibilidade linguística, respeito cultural e continuidade do cuidado. A combinação entre acolhimento humanizado, materiais multilíngues, mediação cultural, registro qualificado, critérios de priorização, salvaguardas e articulação com a rede parceira fortalece a efetividade da proposta e alinha o projeto a padrões internacionais de proteção, equidade e accountability.



13. ENSINO, PESQUISA APLICADA E PRODUÇÃO CIENTÍFICA

O componente de ensino, pesquisa aplicada e produção científica do Projeto Amazônia Sem Fronteiras será desenvolvido em cooperação com a Universidade Federal do Acre, com o objetivo de transformar a assistência humanitária em saúde migratória em uma plataforma qualificada de formação acadêmica, produção de evidências e inovação em saúde para territórios amazônicos e fronteiriços.

A participação de estudantes, docentes, pesquisadores e profissionais de saúde ocorrerá de forma supervisionada, integrada aos fluxos assistenciais do projeto e orientada por princípios éticos, científicos e humanitários. As atividades poderão envolver formação prática, análise de indicadores, estudos epidemiológicos, elaboração de relatórios técnicos, produção de artigos científicos, apresentação de resultados em eventos e sistematização metodológica do modelo de intervenção.

O componente científico irá fortalecer a credibilidade nacional e internacional da proposta, demonstrando que o projeto não se limita à oferta pontual de consultas e exames, mas gera conhecimento aplicado sobre saúde migratória, barreiras de acesso, vulnerabilidades sociais e sanitárias, continuidade do cuidado, sustentabilidade hospitalar, energia limpa e governança ESG aplicada à saúde.

13.1. Integração Ensino-Serviço

A integração ensino-serviço será estruturada por meio da participação supervisionada de estudantes e profissionais em atividades relacionadas ao acolhimento, triagem, educação em saúde, monitoramento de indicadores, pesquisa aplicada e análise dos resultados assistenciais. Essa atuação irá respeitar os limites de competência de cada participante, a supervisão técnica obrigatória e os protocolos institucionais do projeto.

A formação acadêmica buscará desenvolver competências em saúde humanitária, atendimento intercultural, ética em pesquisa, proteção de populações vulneráveis, análise epidemiológica, sustentabilidade hospitalar e ESG aplicado à saúde. Dessa forma, o projeto contribuirá para a formação de profissionais mais preparados para atuar em contextos de vulnerabilidade, mobilidade humana e diversidade sociocultural.



13.2. Pesquisa Aplicada em Saúde Migratória

As pesquisas desenvolvidas no âmbito do projeto poderão abordar temas como perfil epidemiológico da população migrante atendida, barreiras de acesso à saúde, demandas por especialidades médicas, doenças crônicas, saúde materno-infantil, saúde mental, vulnerabilidades sociais, continuidade terapêutica, impactos da mediação intercultural, resolutividade clínica e contribuição da energia limpa para sustentabilidade da assistência humanitária.

Sempre que houver utilização de dados pessoais, prontuários, entrevistas, grupos focais, acompanhamento longitudinal, coleta de informações sensíveis ou participação direta de beneficiários, os respectivos protocolos de pesquisa irão ser submetidos ao Comitê de Ética em Pesquisa, observando as normas éticas aplicáveis à pesquisa com seres humanos.

13.3. Ética, Consentimento e Proteção dos Participantes

A produção científica do projeto irá observar rigorosamente os princípios de dignidade, autonomia, confidencialidade, não discriminação, proteção de populações vulneráveis e uso responsável das informações. Quando aplicável, os participantes irão ser informados de forma clara e acessível sobre os objetivos da pesquisa, os dados a serem utilizados, os riscos e benefícios envolvidos, a possibilidade de recusa, a inexistência de prejuízo ao atendimento em caso de não participação e os mecanismos de proteção das informações.

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido irá ser utilizado sempre que a metodologia exigir consentimento formal, especialmente em entrevistas, grupos focais, coleta direta de informações, uso de imagem, relatos de experiência, estudos longitudinais ou pesquisas que envolvam dados sensíveis não anonimizados. Quando houver barreiras linguísticas, o consentimento irá ser explicado em linguagem acessível, com apoio de mediador cultural ou material traduzido, sempre que necessário.

13.4. Governança de Dados Sensíveis e LGPD

O projeto irá adotar mecanismos de governança de dados sensíveis, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, especialmente por envolver informações de saúde, condição migratória, vulnerabilidades sociais, nacionalidade, idioma, histórico clínico e dados socioassistenciais.

Os dados utilizados para fins científicos irão ser tratados com segurança, minimização, finalidade específica, controle de acesso, anonimização ou pseudonimização sempre que possível. Informações identificáveis somente irão ser



utilizadas quando estritamente necessárias, com base legal adequada, consentimento quando aplicável e procedimentos internos de proteção.

A base de dados do projeto irá diferenciar dados assistenciais, dados administrativos, dados de monitoramento ESG e dados destinados à pesquisa científica. Essa separação permitirá maior segurança, rastreabilidade e controle sobre quem acessa, utiliza, analisa e publica informações relacionadas aos beneficiários.

13.5. Anonimização, Uso de Prontuários e Acompanhamento Longitudinal

A análise de prontuários, relatórios assistenciais, formulários de triagem, registros de exames e dados de acompanhamento longitudinal irá priorizar o uso de informações anonimizadas ou agregadas. Sempre que a identificação individual não for necessária para a finalidade científica, irão ser removidos nomes, documentos, contatos, endereços, imagens, dados migratórios identificáveis e qualquer outro elemento que permita reconhecimento direto ou indireto do beneficiário.

Nos casos em que o acompanhamento longitudinal exigir vinculação de informações ao longo do tempo, poderão ser utilizados códigos internos ou mecanismos de pseudonimização, com controle restrito da chave de identificação. O acesso a essas informações irão ser limitado à equipe autorizada e devidamente capacitada em sigilo, ética em pesquisa e proteção de dados.

13.6. Plano de Publicação Responsável

A disseminação científica dos resultados irá seguir um plano de publicação responsável, garantindo que relatórios, artigos, apresentações, estudos de caso, materiais institucionais e peças de comunicação não exponham indevidamente beneficiários, famílias, nacionalidades específicas ou grupos em situação de vulnerabilidade.

As publicações irão priorizar dados agregados, análises epidemiológicas, indicadores de acesso, resultados assistenciais, metodologias de atendimento intercultural, avaliação de impacto e aprendizados institucionais. Relatos individuais somente poderão ser utilizados mediante autorização específica, proteção da identidade e avaliação prévia de risco de exposição, estigmatização ou revitimização.

O plano de publicação também irá prever revisão técnica e ética antes da divulgação de resultados, especialmente quando envolver dados sensíveis, imagens, histórias de vida, informações sobre condição migratória, violência, saúde mental, crianças, adolescentes, gestantes ou pessoas em situação de proteção.



13.7. Produtos Esperados

Produto	Finalidade
Relatórios técnicos periódicos	Registrar resultados assistenciais, perfil dos beneficiários, produção de consultas e exames, encaminhamentos e indicadores de saúde migratória.
Boletins epidemiológicos	Sistematizar dados agregados sobre demandas de saúde, agravos, vulnerabilidades e barreiras de acesso identificadas no projeto.
Protocolos de pesquisa submetidos ao CEP	Garantir conformidade ética sempre que houver uso de dados pessoais, entrevistas, prontuários ou acompanhamento longitudinal.
Artigos científicos e resumos acadêmicos	Disseminar evidências sobre saúde migratória, sustentabilidade hospitalar, ESG em saúde e modelos de intervenção em territórios de fronteira.
Trabalhos em eventos científicos	Compartilhar aprendizados, resultados e metodologias com a comunidade acadêmica, gestores públicos e parceiros institucionais.
Sistematização metodológica do modelo	Organizar a experiência do projeto para replicação em outros territórios amazônicos e fronteiriços.

O eixo de ensino, pesquisa aplicada e produção científica permitirá que o Projeto Amazônia Sem Fronteiras gere benefícios que ultrapassem o atendimento direto aos migrantes e refugiados. Ao combinar assistência humanitária, formação acadêmica, ética em pesquisa, proteção de dados e publicação responsável, o projeto produzirá evidências relevantes para políticas públicas, qualificação dos serviços de saúde, fortalecimento da ciência amazônica e desenvolvimento de modelos replicáveis de cuidado em contextos de fronteira, mobilidade humana e vulnerabilidade social.

14. SALVAGUARDAS, PROTEÇÃO E ÉTICA

A execução do Projeto Amazônia Sem Fronteiras adotará salvaguardas sociais, sanitárias, éticas, informacionais e humanitárias compatíveis com o atendimento de migrantes, refugiados e demais pessoas em mobilidade internacional em situação de vulnerabilidade. Considerando o perfil do público atendido, que poderá incluir crianças, adolescentes, mulheres, gestantes, idosos, pessoas com deficiência, pessoas indocumentadas, vítimas de violência, pessoas com barreiras linguísticas e indivíduos em insegurança social, o projeto irá assegurar que toda a intervenção seja conduzida com dignidade, confidencialidade, não discriminação, proteção de dados, consentimento informado e responsabilidade institucional.

As salvaguardas irão contemplar, no mínimo, proteção infantil, prevenção de exploração e abuso sexual, proteção contra violência de gênero, não discriminação,



confidencialidade, LGPD, consentimento informado, ética em pesquisa, canal de denúncia, fluxo de encaminhamento para casos de violência ou risco social e mecanismos de resposta a eventos adversos.

Salvaguarda	Medida a ser adotada	Documento ou evidência
Proteção infantil	Atendimento de crianças e adolescentes com protocolo específico, presença de responsável quando aplicável, escuta protegida, registro adequado e encaminhamento à rede de proteção em caso de suspeita de negligência, violência, exploração ou violação de direitos. Triagem sensível a gênero, identificação de riscos de violência doméstica, sexual, exploração, tráfico de pessoas, gestação de risco, saúde sexual e reprodutiva, com encaminhamento protegido à rede especializada.	Política de proteção infantil; fluxo de notificação; termo de ciência da equipe; matriz de encaminhamento ao Conselho Tutelar, assistência social e rede de saúde.
Proteção de mulheres, gestantes vítimas de violência	Adoção de código de conduta para equipe, estudantes, pesquisadores, prestadores e parceiros, com proibição expressa de qualquer forma de exploração, abuso, assédio, favorecimento indevido ou troca de benefício por atendimento.	Protocolo de proteção de gênero; fluxo de encaminhamento para saúde, assistência social, rede de proteção e serviços especializados.
Prevenção de exploração e abuso sexual	Garantia de acolhimento e triagem independentemente de nacionalidade, idioma, raça, religião, gênero, orientação sexual, deficiência, condição econômica ou situação documental, observados os critérios clínicos, sociais e de elegibilidade do projeto.	Política PSEA; código de conduta; termo de ciência e compromisso; plano de resposta a violações; registro de capacitação da equipe.
Não discriminação e equidade de acesso	Ausência de documentação não impedirá acolhimento inicial, triagem socioassistencial ou avaliação clínica. Quando necessário, será criado registro provisório interno, com dados mínimos e proteção da identidade do beneficiário.	Política de não discriminação; critérios de elegibilidade e priorização; formulários padronizados; registros de atendimento e monitoramento de acesso.
Pessoas indocumentadas		Procedimento de registro provisório; ficha de acolhimento; orientação interna sobre atendimento a pessoas indocumentadas.



Salvaguarda	Medida a ser adotada	Documento ou evidência
Consentimento informado	Beneficiários irão receber informações claras sobre os serviços, limites do atendimento, uso de dados, confidencialidade, encaminhamentos e eventual participação em pesquisa, com linguagem acessível e apoio de mediador cultural quando necessário.	Termo de consentimento livre e esclarecido; termo de uso de dados; materiais multilíngues; registro de orientação ao beneficiário.
LGPD e proteção de dados sensíveis	Proteção de prontuários, dados migratórios, informações clínicas, registros socioassistenciais, dados de pesquisa e documentos pessoais, com controle de acesso, finalidade definida, minimização e segurança das informações.	Política de proteção de dados; matriz de acesso a dados; termo de confidencialidade; procedimento de armazenamento e compartilhamento seguro.
Ética pesquisa em	Submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa sempre que houver uso de prontuários, dados pessoais, entrevistas, grupos focais, acompanhamento longitudinal ou coleta de informações sensíveis para fins científicos.	Parecer do CEP quando aplicável; protocolo de pesquisa; termos de consentimento; plano de anonimização; plano de publicação responsável.
Anonimização e publicação responsável	Divulgação de resultados preferencialmente em formato agregado, sem exposição indevida de beneficiários, nacionalidades, crianças, vítimas de violência ou pessoas em situação migratória sensível.	Plano de publicação responsável; procedimento de anonimização; revisão técnica e ética de relatórios, artigos e materiais públicos.
Canal denúncia de feedback	Disponibilização de canal seguro, acessível e, quando necessário, multilíngue para reclamações, denúncias, sugestões, dúvidas e comunicação de eventos adversos, com fluxo de tratamento e resposta.	Procedimento de ouvidoria; formulário de denúncia e feedback; registro de manifestações; relatório de providências adotadas.
Fluxo de encaminhamento para risco social ou violência	Definição de rede de referência para casos de violência, exploração, abandono, situação de rua, insegurança alimentar grave, sofrimento psíquico, risco à criança, gestante ou pessoa com deficiência.	Matriz da rede parceira; protocolo de encaminhamento; registros de contrarreferência; acordos ou cartas de cooperação quando houver.
Capacitação da equipe	Formação obrigatória da equipe do projeto em salvaguardas, proteção infantil, gênero, PSEA, LGPD, consentimento, atendimento intercultural, ética em pesquisa e canais de denúncia.	Plano de capacitação; lista de presença; certificados; materiais formativos; registros de reciclagem periódica.



A implementação dessas salvaguardas será acompanhada pelo comitê de governança do projeto, com revisão periódica dos registros, análise de riscos, tratamento de ocorrências e atualização dos fluxos sempre que necessário. O objetivo é assegurar que a assistência ofertada não apenas amplie o acesso à saúde, mas também proteja as pessoas atendidas contra exposição indevida, discriminação, revitimização, uso inadequado de dados, violações de direitos ou práticas incompatíveis com padrões humanitários internacionais.

Dessa forma, o projeto reforçará sua credibilidade perante financiadores, parceiros institucionais e beneficiários, demonstrando que a intervenção será executada com responsabilidade ética, transparência, proteção integral e accountability.

15. GOVERNANÇA ESG, ACCOUNTABILITY E PRESTAÇÃO DE CONTAS

A governança do Projeto Amazônia Sem Fronteiras será estruturada para assegurar controle técnico, financeiro, assistencial, ambiental e institucional sobre a execução dos recursos, fortalecendo a transparência, a rastreabilidade das despesas e a prestação de contas aos financiadores, parceiros e beneficiários. A estrutura de governança será orientada por princípios ESG, accountability, proteção de dados, integridade financeira, gestão de riscos e demonstração objetiva de impacto.

Do ponto de vista orçamentário-financeiro, o projeto prevê rubricas específicas para Governança ESG, Comunicação, Relatórios ESG e Prestação de Contas, bem como Coordenação Executiva, permitindo que a execução seja acompanhada por instrumentos técnicos de gestão, relatórios periódicos, evidências documentais e controle de entregas. A memória de cálculo prevê R\$75.000,00 para comunicação, relatórios ESG e prestação de contas, financiados pelo concedente, além de R\$300.000,00 de contrapartida econômica do proponente para coordenação executiva do projeto ao longo dos 24 meses.

A governança será organizada a partir de centro de custo próprio, memória de cálculo detalhada, cronograma físico-financeiro trimestral, evidências de execução e relatórios técnicos periódicos. Cada item orçamentário estará vinculado a uma entrega, natureza de despesa, responsável pelo financiamento, fonte de comprovação, ODS associado, período de execução e evidência documental esperada.



Componente de governança	Valor previsto	Responsável pelo recurso	Finalidade
Comunicação, relatórios ESG e prestação de contas	R\$75.000,00	Concedente	Produção de relatórios ESG, sistematização de indicadores, prestação de contas técnica e comunicação institucional dos resultados.
Coordenação executiva do projeto	R\$300.000,00	Proponente	Gestão estratégica, articulação institucional, acompanhamento da execução, coordenação das entregas e controle do cronograma físico-financeiro.
Total vinculado diretamente à governança e gestão	R\$375.000,00	Concedente e Proponente	Sustentação da capacidade de gestão, monitoramento, accountability e transparência do projeto.

A prestação de contas contemplará três dimensões integradas. A dimensão financeira incluirá despesas realizadas, fonte de financiamento, contrapartidas, notas fiscais, contratos, comprovantes de pagamento, demonstrativos de execução e compatibilidade com o cronograma físico-financeiro. A dimensão técnica e assistencial acompanhará beneficiários únicos, consultas, exames, internações, medicações, atendimentos interculturais, estágios, relatórios e produtos científicos. A dimensão ESG e impacto demonstrará energia limpa implantada, economia estimada, ODS atendidos, salvaguardas, comunicação ética, indicadores de governança e resultados sociais.

A execução será monitorada de forma trimestral, permitindo comparar o valor programado com o valor efetivamente executado, identificar eventuais desvios, registrar justificativas e adotar medidas corretivas. Esse modelo fortalece a confiança do financiador, pois demonstra que o projeto dispõe de instrumentos para acompanhar não apenas o gasto, mas a relação entre recurso aplicado, entrega realizada, evidência documental e impacto gerado.

Essa arquitetura de governança permitidemonstrará aos financiadores nacionais e internacionais que o projeto dispõe de mecanismos concretos de controle, participação, transparência, prestação de contas, proteção de populações vulneráveis e compromisso com impacto mensurável.



Instância		Composição	Responsabilidades
Coordenação Geral do Projeto		iSanté	Realizar a gestão estratégica do projeto, integrar os componentes assistencial, energético, científico, social e ESG, acompanhar cronograma, orçamento, metas, riscos e prestação de contas ao financiador.
Coordenação Assistencial		Hospital Silvestre Santé, com apoio técnico do iSanté	Coordenar protocolos clínicos, acolhimento humanitário, triagem, agendas médicas, prontuários, segurança do paciente, qualidade assistencial, encaminhamentos e acompanhamento dos beneficiários. Coordenar integração ensino-serviço, estágio supervisionado, pesquisas aplicadas, produção científica, relatórios técnicos, ética em pesquisa, submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa quando aplicável e plano de publicação responsável.
Coordenação Acadêmica Científica		e UFAC e iSanté	Monitorar indicadores assistenciais, sociais, ambientais, energéticos, científicos e financeiros; consolidar relatórios ESG; manter painel de impacto; acompanhar riscos, compliance, salvaguardas e medidas corretivas.
Coordenação ESG e Monitoramento de Impacto		iSanté, com consultoria técnica quando aplicável	Acompanhar aplicação das políticas de proteção infantil, gênero, PSEA, não discriminação, LGPD, consentimento informado, canal de denúncia, fluxo de encaminhamento para casos de violência, risco social ou violação de direitos.
Coordenação de Proteção e Salvaguardas		iSanté, equipe socioassistencial, representantes da rede parceira e ponto focal de proteção	Promover escuta ativa, validar percepções sobre barreiras de acesso, apoiar adequação cultural e linguística dos protocolos, analisar feedback dos beneficiários, sugerir melhorias e fortalecer accountability junto às populações afetadas.
Comitê Consultivo Comunitário		Representantes de instituições que atuam com migrantes, rede socioassistencial, organizações humanitárias, unidades de acolhimento, profissionais do SUS, estudantes e, quando possível, representantes da população migrante beneficiária	Apoiar identificação, encaminhamento, contrarreferência, proteção social, continuidade do cuidado, orientação territorial e resposta a situações de risco social, violência, insegurança alimentar ou vulnerabilidade extrema.
Rede Parceira de Encaminhamento		SUS, assistência social, CRAS, CREAS, unidades de acolhimento, organizações da sociedade civil, instituições religiosas, universidades e demais atores territoriais envolvidos com migrantes	



Instância		Composição	Responsabilidades
Auditoria Revisão Externa	ou	Profissional ou instituição independente, quando viável	Realizar validação periódica dos dados financeiros, assistenciais, ambientais e de impacto; revisar amostras de registros; verificar coerência entre execução, metas, indicadores e prestação de contas.
	ou	Concedente, investidor ESG, organismo internacional ou parceiro corporativo	Acompanhar relatórios técnicos e financeiros, participar de reuniões de monitoramento quando previsto, avaliar resultados, apoiar comunicação institucional e validar entregas pactuadas.

15.1. Mecanismos de Accountability

A prestação de contas do projeto combinará transparência financeira, demonstração de resultados e escuta dos beneficiários. Para isso, serão adotados mecanismos formais de acompanhamento, incluindo relatórios periódicos, reuniões de governança, painel de indicadores, registro de atendimentos, controle de execução orçamentária, documentação das decisões do comitê e sistematização dos feedbacks recebidos.

O projeto irá manter registros claros sobre pessoas únicas atendidas, atendimentos realizados, consultas, exames, retornos, urgências, acompanhamentos, encaminhamentos, atendimentos com mediação cultural, manifestações recebidas no canal de feedback e providências adotadas. Esses dados irão subsidiar relatórios técnicos e ESG, permitindo demonstrar a relação entre investimento, atividades executadas, resultados alcançados e impacto gerado.



15.2. Participação Social e Escuta dos Beneficiários

A participação social será incorporada como elemento permanente da governança, e não apenas como consulta inicial. O Comitê Consultivo Comunitário irá reunir-se periodicamente para analisar barreiras percebidas, qualidade do acolhimento, acessibilidade linguística, adequação dos fluxos, efetividade dos encaminhamentos, riscos de proteção e oportunidades de melhoria.

Sempre que possível, a escuta incluirá migrantes e refugiados atendidos pelo projeto, preservando voluntariedade, confidencialidade e segurança. A participação de beneficiários não irá expor pessoas em situação documental frágil, vítimas de violência ou indivíduos em condição de vulnerabilidade sensível. Quando a participação direta não for recomendável, poderão ser utilizados mecanismos protegidos de feedback anônimo, entrevistas mediadas ou consulta por organizações parceiras.

15.3. Prestação de Contas e Relatórios

A prestação de contas contemplará três dimensões complementares:

Dimensão	Conteúdo mínimo
Financeira	Execução orçamentária, despesas realizadas, contrapartidas, saldos, notas fiscais, contratos, pagamentos, memória de cálculo e compatibilidade com o cronograma físico-financeiro.
Técnica e assistencial	Metas executadas, pessoas atendidas, consultas, exames, retornos, urgências, encaminhamentos, perfil dos beneficiários, resolutividade, produção científica e atividades formativas.
ESG e impacto	Energia gerada, economia financeira, redução estimada de emissões, valor convertido em assistência, indicadores sociais, salvaguardas, feedback dos beneficiários, riscos monitorados e medidas corretivas.

A governança proposta fortalecerá o projeto ao combinar gestão técnica, controle financeiro, monitoramento ESG, proteção de beneficiários, produção científica e participação social. A presença de instituições que atuam com migrantes e, sempre que possível, de representantes da população beneficiária no Comitê Consultivo Comunitário ampliará a legitimidade da intervenção, melhorará a qualidade dos protocolos e demonstrará compromisso efetivo com accountability, equidade e centralidade das pessoas afetadas.



16. INDICADORES DE IMPACTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

O monitoramento do Projeto Amazônia Sem Fronteiras será estruturado por uma matriz de indicadores SMART, organizados em dimensões sociais, assistenciais, humanitárias, ambientais, acadêmicas, financeiras e de governança. A matriz permitirá acompanhar a execução física e financeira, medir resultados, demonstrar impacto, corrigir rotas e prestar contas a financiadores, parceiros institucionais e beneficiários.

Cada indicador irá conter linha de base, meta anual, meta total, fórmula de cálculo, periodicidade, fonte de dados, responsável e evidência documental. Essa estrutura é essencial para elevar a qualidade técnica da proposta, pois demonstra capacidade de mensuração, rastreabilidade, transparência e accountability, critérios altamente valorizados por organismos internacionais, investidores ESG e financiadores multilaterais.

A matriz irá ser revisada após a etapa de validação participativa da Teoria da Mudança, considerando a escuta comunitária com migrantes, profissionais do SUS, assistência social, estudantes, parceiros institucionais e organizações que atuam com a população migrante no Acre.



16.1. Matriz de Indicadores do Projeto

Dimensão	Indicador	Baseline preliminar	Meta	Meta total 24 meses	Fórmula de cálculo	Periodicidade	Fonte de dados	Responsável	Evidência documental
Migração e alcance territorial	Pessoas migrantes e únicas refugiadas cadastradas	0 no início do projeto	Semestre 2: 432 beneficiários Semestre 3: 432 beneficiários Semestre 4: 432 beneficiários	1.296 beneficiários diretos	Soma de beneficiários únicos cadastrados, sem duplicidade	Semestral e anual	Cadastro do projeto; ficha de acolhimento	Coordenação Assistencial	Relatório de cadastro; base nominal protegida; painel consolidado
Migração e alcance territorial	Nacionalidades atendidas	Linha de base migratória aponta fluxos relevantes de Peru, Bolívia, Venezuela, Haiti, Senegal, Colômbia e Equador	Registrar 100% das nacionalidades dos beneficiários atendidos	Perfil consolidado por nacionalidade ao final do projeto	Nº de beneficiários por nacionalidade dividido pelo total de beneficiários cadastrados	Semestral e anual	Ficha cadastral; triagem social	Coordenação Assistencial e ESG	Relatório de perfil dos beneficiários
Saúde	Consultas clínicas gerais realizadas	0 no início do projeto	Semestre 2: 430 consultas Semestre 3: 432 consultas Semestre 4: 434 consultas	1.296 consultas	Soma de consultas clínicas gerais realizadas	Semestral	Agenda médica; prontuário	Coordenação Assistencial	Relatório assistencial; agenda; prontuários
Saúde	Consultas especializadas realizadas	0 no início do projeto	Semestre 2: 258 consultas Semestre 3: 260 consultas Semestre 4: 260 consultas	778 consultas	Soma de consultas por especialidade	Semestral	Agenda médica; prontuário	Coordenação Assistencial	Relatório por especialidade; prontuários
Saúde	Exames laboratoriais realizados	0 no início do projeto	Semestre 2: 1.296 exames Semestre 3: 1.296 exames Semestre 4: 1.296 exames	3.888 exames laboratoriais	Soma de exames laboratoriais realizados	Semestral	Sistema laboratorial; laudos	Coordenação Assistencial	Laudos; relatório laboratorial
Saúde	Exames de imagem realizados	0 no início do projeto	Semestre 2: 108 exames Semestre 3: 108 exames Semestre 4: 108 exames	324 exames de imagem	Soma de exames de imagem realizados	Semestral	Sistema de imagem; laudos	Coordenação Assistencial	Laudos de imagem; relatório mensal



Dimensão	Indicador	Baseline preliminar	Meta	Meta total 24 meses	Fórmula de cálculo	Periodicidade	Fonte de dados	Responsável	Evidência documental
Saúde	Atendimentos de urgência ou suporte hospitalar	0 no início do projeto	Semestre 2: 65 diárias de internação Semestre 3: 65 diárias de internação Semestre 4: 65 diárias de internação Registrar e monitorar mulheres, crianças, gestantes, idosos, pessoas com deficiência e doenças crônicas	195 diárias de internação	Soma de atendimentos classificados como urgência ou suporte hospitalar	Semestral	Ficha de atendimento; prontuário	Coordenação Assistencial	Registro hospitalar; evolução clínica
Proteção humanitária	Beneficiários de grupos prioritários atendidos	0 no início do projeto	Registrar e monitorar mulheres, crianças, gestantes, idosos, pessoas com deficiência e doenças crônicas	Perfil consolidado dos grupos prioritários	Nº de beneficiários por grupo prioritário dividido pelo total de beneficiários x 100	Semestral	Ficha social; triagem clínica	Coordenação de Proteção	Relatório de vulnerabilidade
Proteção humanitária	Atendimentos com mediação intercultural linguística ou	0 no início do projeto	Registrar dos atendimentos com mediação	Série histórica de mediações realizadas	Nº de atendimentos com mediador, intérprete ou apoio linguístico	Semestral	Registro de mediação; prontuário	Coordenação Assistencial e Mediador Cultural	Ficha de mediação; relatório linguístico
Proteção humanitária	Idioma preferencial registrado	0 no início do projeto	100% dos beneficiários cadastrados com idioma registrado	100% dos beneficiários cadastrados	Nº de cadastros com idioma preenchido dividido pelo total de cadastros x 100	Semestral	Ficha de acolhimento	Equipe de Acolhimento	Relatório cadastral
Proteção humanitária	Materiais multilíngues produzidos	0 no início do projeto	Produzir materiais em português e espanhol; francês/creole haitiano quando aplicável	Kit multilíngue implantado e atualizado	Nº de materiais produzidos por idioma	Semestral	Plano de comunicação; materiais impressos e digitais	Coordenação ESG e Comunicação	Cartilhas, folders, termos e registros de distribuição
Proteção humanitária	Reclamações, denúncias e feedbacks recebidos e tratados	0 no início do projeto	100% das manifestações registradas e tratadas	Sistema de feedback consolidado	Nº de manifestações tratadas dividido pelo nº de manifestações recebidas x 100	Semestral	Canal de denúncia; ouvidoria; formulário de feedback	Coordenação de Proteção e ESG	Relatório de manifestações e providências
Proteção humanitária	Casos encaminhados à rede de proteção	0 no início do projeto	Registrar e acompanhar 100% dos casos identificados	Série histórica de encaminhamentos protegidos	Nº de casos encaminhados à rede de proteção	Semestral	Ficha social; registro de encaminhamento	Coordenação de Proteção	Encaminhamentos; contrarreferência; relatório socioassistencial



Dimensão	Indicador	Baseline preliminar	Meta	Meta total 24 meses	Fórmula de cálculo	Periodicidade	Fonte de dados	Responsável	Evidência documental
Proteção humanitária	Equipe capacitada em salvaguardas	0 no início do projeto	Capacitar 100% da equipe direta no Ano 1 e reciclar no Ano 2	100% da equipe direta capacitada	N° de membros capacitados dividido pelo total de membros da equipe x 100	Semestral	Lista de presença; certificados	Coordenação de Proteção	Plano de capacitação; certificados; listas
Energia clima	e Energia limpa gerada	0 antes da implantação	Medir geração mensal após ativação do sistema	Série acumulada em kWh ao final de 24 meses	Soma de kWh gerados pelo sistema fotovoltaico	Mensal	Sistema de monitoramento energético	Coordenação e Empresa Técnica	Dashboard energético; relatórios técnicos
Energia clima	e Economia financeira mensal e anual	Baseline: fatura média anterior ao projeto	Economia estimada de R\$ 336.900,00 por ano	R\$ 673.800,00 em 2 anos, se mantida a estimativa anual	Fatura de referência menos fatura pós-implantação	Mensal e anual	Faturas de energia; estudo técnico; dashboard	Coordenação e ESG Financeira	Faturas; relatório de economia
Energia clima	e Percentual de redução da fatura energética	Baseline a partir das faturas pré-projeto	Redução estimada em torno de 67%, conforme estudo técnico	Média consolidada de redução ao final do projeto	Valor economizado dividido pela fatura de referência x 100	Mensal	Faturas de energia; estudo técnico	Coordenação ESG	Relatório comparativo de faturas
Energia clima	e Valor convertido em assistência médica gratuita	0 antes da operação do modelo	Converter economia energética em serviços assistenciais conforme plano anual	Valor acumulado convertido ao final do projeto	Valor da economia aplicada em atendimentos gratuitos	Semestral	Relatório financeiro; memória de cálculo assistencial	Coordenação e Financeira Assistencial	Relatório financeiro; demonstrativo de conversão
Energia clima	e Emissões de CO ₂ equivalente evitadas	0 antes da implantação	Calcular anualmente após definição da metodologia	Total acumulado de CO ₂ evitado em 24 meses	kWh gerados por fonte renovável x fator de emissão adotado	Anual	Dashboard energético; metodologia de cálculo	Coordenação ESG	Relatório ambiental; memória de cálculo
Energia clima	e Desempenho do BESS	0 antes da implantação	Monitorar ciclos, uso e suporte ao horário de ponta	Série histórica de desempenho	Energia armazenada e descarregada pelo BESS; ciclos realizados	Mensal	Sistema de monitoramento BESS	Empresa integradora	Dashboard BESS; relatório técnico
Ensino formação	e Horas de formação ofertadas	0 no início do projeto	Carga horária anual por trilha	Carga horária total consolidada	Soma de horas-aula ofertadas	Semestral	Plano de formação; listas	Coordenação Acadêmica	Programação; materiais; certificados
Ensino formação	e Estudantes envolvidos em prática supervisionada	0 no início do projeto	03 alunos semestralmente	09 alunos ao final do projeto	N° de estudantes participantes	Semestral	Relatórios acadêmicos; listas	Coordenação Acadêmica	Relatórios de estágio; listas; declarações
Pesquisa aplicada	e Pesquisas iniciadas sobre saúde migratória	0 no início do projeto	Meta anual conforme plano científico	Meta total a definir com UFAC e iSanté	N° de projetos de pesquisa iniciados	Anual	Plano científico; registros institucionais	Coordenação Científica	Projetos de pesquisa; atas; relatórios



Dimensão	Indicador	Baseline preliminar	Meta	Meta total 24 meses	Fórmula de cálculo	Periodicidade	Fonte de dados	Responsável	Evidência documental
Pesquisa aplicada	Protocolos submetidos ou aprovados no CEP	0 no início do projeto	Submeter 100% dos estudos que exigirem avaliação ética	100% dos estudos aplicáveis submetidos	N° de estudos submetidos ao CEP dividido pelo n° de estudos que exigem CEP x 100	Anual	Plataforma Brasil; Comitê de Ética	Coordenação Científica	Parecer protocolo de pesquisa
Pesquisa aplicada	Relatórios epidemiológicos produzidos	0 no início do projeto	Pelo menos 1 relatório anual	2 relatórios anuais	N° de relatórios produzidos	Anual	Base assistencial anonimizada; indicadores	Coordenação Científica e ESG	Relatórios epidemiológicos
Governança ESG	Relatórios emitidos	0 no início do projeto	Relatórios trimestrais ou semestrais, conforme pactuação	Série completa de relatórios ao longo de 24 meses	N° de relatórios emitidos	Trimestral ou semestral	Painel de indicadores; relatórios técnicos	Coordenação ESG	Relatórios ESG
Governança ESG	Reuniões do Comitê de Governança	0 no início do projeto	Realizar reuniões periódicas trimestralmente	Atas consolidadas em 24 meses	N° de reuniões realizadas	Trimestral	Atas do comitê	Coordenação Geral	Atas; listas de presença
Governança ESG	Reuniões do Comitê Consultivo Comunitário	0 no início do projeto	Realizar reuniões periódicas com rede migratória e, quando possível, beneficiários	Atas e recomendações consolidadas	N° de reuniões realizadas	Semestral	Atas; registros de escuta	Coordenação ESG e Proteção	Atas; relatórios de escuta; recomendações
Governança ESG	Recomendações comunitárias analisadas e respondidas	0 no início do projeto	100% das recomendações registradas com resposta	Sistema de resposta consolidado	N° de recomendações respondidas dividido pelo n° de recomendações recebidas x 100	Semestral	Comitê Consultivo; feedbacks	Coordenação ESG	Matriz de recomendações e providências
Governança ESG	Riscos tratados	Matriz inicial de riscos do projeto	100% dos riscos críticos com plano de resposta	Histórico de gestão de riscos	N° de riscos críticos com ação definida dividido pelo total de riscos críticos x 100	Trimestral	Matriz de riscos	Coordenação Geral e ESG	Matriz de riscos atualizada
Governança ESG	Execução financeira do projeto	0 no início do projeto	Executar conforme cronograma físico-financeiro	100% da execução compatível com entregas aprovadas	Valor executado dividido pelo valor previsto x 100	Mensal e trimestral	Planilha financeira; notas fiscais	Coordenação Financeira	Relatórios financeiros; notas; extratos
Governança ESG	Auditoria ou revisão externa realizada	0 no início do projeto	Pelo menos 1 revisão anual, quando viável	Até 4 revisões anuais	N° de auditorias ou revisões realizadas	Anual	Relatórios externos	Coordenação Geral	Relatório de auditoria ou revisão



Dimensão	Indicador	Baseline preliminar	Meta anual	Meta total 24 meses	Fórmula de cálculo	Periodicidade	Fonte de dados	Responsável	Evidência documental
Accountability	Satisfação dos beneficiários	0 no início do projeto	Aplicar pesquisa periódica e estabelecer meta após primeira medição	Série histórica de satisfação	$\frac{\text{Nº de beneficiários satisfeitos}}{\text{dividido pelo nº de respondentes}} \times 100$	Semestral	Pesquisa de satisfação	Coordenação ESG e Comitê Consultivo	Relatório de satisfação
Accountability	Beneficiários que relatam melhora no acesso à saúde	0 no início do projeto	Estabelecer meta após primeira medição	Série histórica de percepção de acesso	$\frac{\text{Nº de beneficiários que relatam melhora}}{\text{dividido pelo nº de respondentes}} \times 100$	Semestral	Pesquisa de percepção; entrevistas	Coordenação ESG e Científica	Relatório de percepção de acesso
Accountability	Dados publicados em painel ou relatório público	0 no início do projeto	Publicar dados agregados periodicamente	Série pública de resultados agregados	$\frac{\text{Nº de atualizações publicadas}}{\text{dividido pelo nº de respondentes}} \times 100$	Anual	Relatórios ESG; painel institucional	Coordenação ESG e Comunicação	Painel, relatório público ou boletim



16.2. Diretrizes para Gestão dos Indicadores

Os indicadores serão coletados em instrumentos padronizados, com campos obrigatórios, responsáveis definidos e rotinas de conferência. A base de dados do projeto diferenciará informações assistenciais, sociais, energéticas, financeiras, acadêmicas e de proteção, evitando duplicidade de registros e permitindo análise integrada dos resultados.

Para garantir confiabilidade, serão adotadas as seguintes diretrizes:

Diretriz	Aplicação prática
Separação entre pessoa única e atendimento	O projeto irá diferenciar beneficiário individual de quantidade total de serviços realizados, evitando superestimação dos resultados.
Registro de nacionalidade e idioma	Todo cadastro irá conter nacionalidade e idioma preferencial, permitindo adequação dos materiais multilíngues e acionamento de mediação cultural.
Desagregação de dados	Sempre que possível, os dados irão ser desagregados por sexo, idade, nacionalidade, idioma, grupo prioritário, tipo de atendimento e situação de vulnerabilidade.
Proteção de dados	Indicadores públicos irão ser apresentados em formato agregado, sem identificação de beneficiários ou exposição de dados sensíveis.
Validação periódica	Os dados irão ser revisados pela Coordenação ESG, Coordenação Assistencial e Comitê de Governança antes da submissão aos financiadores.
Correção de rota	Resultados abaixo da meta irão gerar análise de causa, plano de ação corretivo e registro das providências adotadas.
Participação social	O Comitê Consultivo Comunitário irá analisar resultados selecionados, especialmente os relacionados a acesso, barreiras, mediação intercultural, satisfação e proteção.

16.3. Produtos de Monitoramento e Avaliação

Produto	Periodicidade	Finalidade
Relatório técnico-assistencial	Trimestral	Consolidar pessoas atendidas, consultas, exames, retornos, urgências, encaminhamentos e acompanhamentos.
Relatório ESG	Semestral	Demonstrar resultados sociais, ambientais, financeiros, de governança e proteção.
Boletim epidemiológico de saúde migratória	Anual	Sistematizar dados agregados sobre perfil dos beneficiários, demandas clínicas, agravos e barreiras de acesso.
Relatório energético	Mensal	Monitorar geração de energia, economia financeira, desempenho do BESS e redução estimada de emissões.
Relatório de salvaguardas e proteção	Semestral	Acompanhar feedbacks, denúncias, encaminhamentos de proteção, mediação intercultural e riscos sociais.
Relatório de avaliação de impacto	Final do projeto	Avaliar resultados acumulados, efetividade do modelo, sustentabilidade e potencial de replicabilidade.
Painel de indicadores	Atualização periódica	Apoiar tomada de decisão, prestação de contas e comunicação de resultados aos parceiros e financiadores.

A matriz de indicadores permitidemonstrará que o projeto possui capacidade de transformar recursos financeiros e infraestrutura energética em resultados



mensuráveis de saúde, proteção, formação, ciência, sustentabilidade e governança. Ao vincular cada indicador a baseline, metas, fórmula de cálculo, fonte de dados, responsável e evidência documental, a proposta fortalece sua credibilidade perante organismos internacionais, reduz riscos de execução e amplia a capacidade de comprovar impacto social, ambiental e institucional ao longo dos 24 meses.



17. MATRIZ LÓGICA

Resultado esperado	Indicador	Linha de base	Meta 24 meses	Fonte de verificação	Pressupostos críticos
R1. Infraestrutura energética sustentável implantada	Sistema solar fotovoltaico e BESS instalado, homologado e operacional.	Sistema fotovoltaico com BESS ainda não implantado no modelo proposto de conversão de economia energética em assistência humanitária.	Implantar sistema solar fotovoltaico de 404,46 kWp, associado a sistema BESS operacional, integrado ao consumo hospitalar e monitorado.	Contratos, notas fiscais, ART, relatórios técnicos, homologação, registros fotográficos, laudos de instalação e dashboard energético.	Disponibilidade de recursos, contratação de empresa especializada, regularidade técnica dos equipamentos, homologação pela concessionária e viabilidade operacional do sistema.
R2. Economia energética convertida em saúde humanitária	Valor financeiro economizado com energia e formalmente aplicado em serviços gratuitos de saúde.	R\$ 0 convertido formalmente pelo modelo proposto antes da implantação do sistema.	Converter economia operacional estimada de R\$ 336.900,00 por ano em assistência médica gratuita, totalizando referência potencial de R\$ 673.800,00 em 24 meses, conforme desempenho do sistema.	Faturas de energia, relatórios financeiros, demonstrativo de economia, memória de cálculo, plano de aplicação dos recursos e relatório de conversão social.	Geração energética compatível com premissas técnicas, estabilidade tarifária razoável, controle financeiro da economia gerada e vinculação formal da economia ao plano assistencial.
R3. Migrantes e refugiados atendidos com acesso gratuito à saúde	Número de beneficiários diretos únicos cadastrados e atendidos.	Antes do projeto, inexistência de modelo estruturado e mensurável do iSanté voltado especificamente ao atendimento gratuito continuado de migrantes e refugiados.	Atender 1.296 beneficiários diretos únicos ao longo de 24 meses, com priorização de pessoas em maior vulnerabilidade social, sanitária, econômica, linguística ou documental.	Cadastro do projeto, fichas de acolhimento, prontuários, registros de triagem, relatórios assistenciais e painel de beneficiários.	Adesão dos beneficiários, articulação com rede parceira, funcionamento dos fluxos de acolhimento, disponibilidade de equipe e manutenção da capacidade assistencial.
R5. Protocolo assistencial humanitário e intercultural implantado	Protocolos de acolhimento, elegibilidade, triagem, priorização, mediação intercultural, encaminhamento e acompanhamento elaborados, validados e aplicados.	Protocolos específicos para saúde migratória humanitária ainda não formalizados no modelo proposto.	Validar a Teoria da Mudança com parceiros e beneficiários; elaborar e implantar protocolos assistenciais e interculturais multilíngues, com materiais em português, espanhol e, quando aplicável, francês ou crioulo haitiano.	Atas de validação, relatórios de escuta comunitária, protocolos aprovados, materiais multilíngues, fichas de mediação cultural e registros de atendimento.	Participação de parceiros, disponibilidade de mediadores culturais, adesão da equipe aos protocolos e adequação dos materiais às barreiras reais de acesso.
R6. Proteção, salvaguardas e ética institucionalizadas	Políticas e fluxos de proteção infantil, gênero, não discriminação, PSEA, LGPD, consentimento informado, ética em pesquisa, canal de denúncia e encaminhamento de riscos implementados.	Salvaguardas específicas do projeto ainda pendentes de formalização antes da submissão e implantação.	Implantar política mínima de salvaguardas, capacitar a equipe, manter canal de denúncia e registrar 100% dos casos de risco social ou proteção encaminhados conforme fluxo definido.	Políticas aprovadas, código de conduta, termos de confidencialidade, registros de capacitação, canal de denúncia, relatórios de proteção e registros de encaminhamento.	Compromisso institucional, capacitação continuada, funcionamento da rede de proteção e confidencialidade no tratamento de casos sensíveis.



A lógica deste projeto parte de um problema territorial concreto: o Acre registra fluxo migratório internacional expressivo, com 358.439 entradas de estrangeiros entre 2015 e abril de 2026 e saldo migratório positivo de 41.309 pessoas, o que amplia a pressão sobre um território amazônico com oferta limitada de especialidades médicas. A resposta proposta combina infraestrutura energética sustentável, assistência humanitária em saúde, protocolos interculturais, salvaguardas, pesquisa aplicada, formação profissional e governança ESG.

Ao implantar energia limpa e converter a economia operacional em atendimentos gratuitos, o projeto criará um mecanismo de financiamento social. Ao organizar protocolos, indicadores e mecanismos de proteção, assegura transparência, equidade e accountability. Ao produzir dados e evidências científicas, transforma a assistência em conhecimento aplicável para políticas públicas e replicação em outros territórios de fronteira.

18. PLANO ORÇAMENTÁRIO, CUSTO-EFETIVIDADE E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA

O Plano Orçamentário-Financeiro do Projeto Amazônia Sem Fronteiras foi estruturado com base na memória de cálculo das atividades financiáveis, organizando os custos por grupo de despesa, natureza de despesa, categoria, unidade de medida, quantidade, valor unitário, valor total, responsável pelo financiamento, contrapartida, ODS, período de execução e evidência documental.

O orçamento foi organizado para demonstrar com clareza a relação entre investimento, entrega, evidência e impacto. Cada componente financeiro está vinculado a uma finalidade técnica, a uma etapa de execução e a um resultado esperado, permitindo acompanhamento objetivo da aplicação dos recursos, análise de custo-efetividade e prestação de contas com padrões de qualidade e segurança.

A memória de cálculo indica valor global de R\$2.980.320,00 para execução ao longo de 24 meses, sendo R\$2.455.320,00 solicitados ao concedente e R\$525.000,00 correspondentes à contrapartida econômica do proponente. A contrapartida representa aproximadamente 17,62% do orçamento global, reforçando o compromisso institucional do iSanté e do ecossistema Silvestre Santé com a execução e sustentabilidade do projeto.



18.1. Composição orçamentária consolidada

Grupo de despesa	Valor total	Concedente	Proponente	% Orçamento
Infraestrutura Energetica	R\$ 1.349.570,00	R\$ 1.349.570,00	R\$ 0,00	45,28%
Atendimento Humanitario	R\$ 1.367.950,00	R\$ 962.950,00	R\$ 405.000,00	45,90%
Ensino e Pesquisa	R\$ 64.800,00	R\$ 64.800,00	R\$ 0,00	2,17%
Comunicacao e Disseminacao	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 0,00	1,61%
Governanca ESG	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	1,01%
Gestao do Projeto	R\$ 120.000,00	R\$ 0,00	R\$ 120.000,00	4,03%
Total	R\$ 2.980.320,00	R\$ 2.455.320,00	R\$ 525.000,00	100,00%

A maior concentração orçamentária está no eixo de Atendimento Humanitário, que representa 45,90% do orçamento global, demonstrando que a proposta mantém foco direto na oferta de serviços de saúde aos migrantes e refugiados. A segunda maior rubrica corresponde à Infraestrutura Energética, com 45,28% do orçamento, evidenciando o caráter estruturante do investimento em energia limpa como mecanismo de sustentabilidade financeira e impacto social continuado.

18.2. Composição por natureza de despesa

Natureza de despesa	Valor total	Participação
Custeio	R\$2.094.590,00	70,28%
Investimento	R\$885.730,00	29,72%
Total	R\$2.980.320,00	100,00%

O orçamento apresenta predominância de despesas de custeio, especialmente vinculadas à execução assistencial, consultas, exames, internações, medicação, bolsas de estágio, comunicação, governança e coordenação. As despesas de investimento concentram-se na aquisição dos principais equipamentos fotovoltaicos e do sistema BESS, essenciais para a implantação da infraestrutura energética sustentável.

18.3. Composição por fonte de financiamento

Fonte de recurso	Valor	Participação
Concedente	R\$2.455.320,00	82,38%
Proponente	R\$525.000,00	17,62%
Total	R\$2.980.320,00	100,00%

A participação do proponente é expressiva e fortalece a credibilidade financeira da proposta. A contrapartida econômica está concentrada em dois itens estratégicos: atendimento médico clínico geral, no valor de R\$405.000,00, e gestão executiva do projeto, no valor de R\$120.000,00. Essa composição demonstra que o proponente



assume parcela relevante da execução assistencial e gerencial, reduzindo os riscos e ampliando a sustentabilidade institucional da proposta.

18.4. Memória de cálculo assistencial e custo-efetividade

O eixo assistencial foi dimensionado para atender 1.296 beneficiários diretos únicos ao longo de 24 meses, com carteira de serviços composta por atendimento clínico geral, consultas especializadas, exames laboratoriais, exames de imagem, diárias de internação, aplicação ou entrega de medicação e atendimento humanitário intercultural.

Serviço assistencial	Quantidade	Valor unitário	Valor total	Responsável pelo recurso
Atendimento humanitário intercultural	1.296	R\$ 41,67	R\$ 54.000,00	Concedente
Atendimento medico clinico geral	1.296 consultas	R\$ 312,50	R\$ 405.000,00	Proponente
Consulta médica especialista (cardiologista, infectologista, neurologista, reumatologista, ginecologista, pediatra)	778 consultas	R\$ 400,00	R\$ 311.200,00	Concedente
Exames laboratoriais diversos	3.888 exames médicos	R\$ 90,00	R\$ 349.920,00	Concedente
Exames de imagem	324 exames de imagem	R\$ 350,00	R\$ 113.400,00	Concedente
Diária Internação	195 diárias	R\$ 450,00	R\$ 87.750,00	Concedente
Aplicação ou entrega de medicação	389 unidade	R\$ 120,00	R\$ 46.680,00	Concedente
Total assistencial	—	—	R\$1.367.950,00	Concedente e Proponente

A análise de custo-efetividade demonstra que o custo global médio por beneficiário direto é de aproximadamente R\$2.299,63, considerando o orçamento total de R\$2.980.320,00 dividido pelos 1.296 beneficiários diretos previstos. Quando considerados apenas os custos assistenciais, o custo médio é de aproximadamente R\$1.055,52 por beneficiário direto, incluindo consultas, exames, internações, medicação e atendimento intercultural.

Importante destacar que esse projeto não oferece apenas acolhimento ou orientação pontual, mas uma carteira integrada de serviços de saúde, com possibilidade de consulta clínica, consulta especializada, exames laboratoriais, exames de imagem, suporte hospitalar, medicação, mediação intercultural e acompanhamento conforme critérios de vulnerabilidade e prioridade clínica.

18.5. Sustentabilidade financeira

A sustentabilidade financeira do projeto foi concebida para proteger o investimento realizado e será fortalecida por três mecanismos principais. O primeiro é a implantação da infraestrutura energética, no valor de R\$1.349.570,00, que permitirá



reduzir custos operacionais hospitalares e criar base permanente para conversão da economia em assistência social. O segundo é a contrapartida econômica do proponente, no valor de R\$525.000,00, que demonstra compromisso institucional do ecossistema Silvestre Santé. O terceiro é a estrutura de governança, monitoramento e prestação de contas, que permitirá comprovar a relação entre recurso aplicado, economia gerada, serviço realizado e impacto social produzido.

Dessa forma, o orçamento está compreendido também como investimento estruturante, e não apenas como financiamento de custeio. O recurso solicitado ao concedente viabiliza a implantação da infraestrutura energética, a ampliação da assistência humanitária, a formação acadêmica, a produção de evidências e a governança ESG. Já a contrapartida do proponente garante suporte assistencial e gerencial essencial para a execução do projeto.

19. SUSTENTABILIDADE PÓS-FINANCIAMENTO

A sustentabilidade pós-financiamento do Projeto Amazônia Sem Fronteiras será estruturada a partir da própria lógica de intervenção da proposta: transformar uma resposta territorial a um desafio migratório concreto em um modelo permanente de saúde humanitária, energia limpa, produção de evidências, formação profissional e governança ESG.

A lógica do projeto parte de um problema territorial mensurável: entre 2015 e 2026, o Acre registrou 358.439 entradas de estrangeiros e saldo migratório positivo de 41.309 pessoas, ampliando a pressão sobre um território amazônico de fronteira internacional, com oferta limitada de especialidades médicas e necessidade crescente de respostas interculturais, contínuas e qualificadas. Diante desse cenário, a proposta combina infraestrutura energética sustentável, assistência humanitária em saúde, protocolos interculturais, salvaguardas, pesquisa aplicada, formação profissional e governança ESG.

Ao implantar energia limpa e converter a economia operacional em atendimentos gratuitos, o projeto cria um mecanismo recorrente de financiamento social. Ao organizar protocolos, indicadores, critérios de elegibilidade, salvaguardas e mecanismos de proteção, assegura transparência, equidade e accountability. Ao produzir dados e evidências científicas, transforma a assistência em conhecimento aplicável para políticas públicas, captação de novos recursos e replicação em outros territórios amazônicos e de fronteira.

Assim, a sustentabilidade pós-financiamento não dependerá de um único mecanismo, mas de uma combinação de estratégias financeiras, institucionais, científicas e territoriais, capazes de manter o impacto social após o ciclo inicial de 24 meses.



Mecanismo de sustentabilidade	Descrição estratégica
Economia energética recorrente	A economia gerada pelo sistema solar fotovoltaico e BESS continuará sendo utilizada como fonte permanente de apoio a atendimentos gratuitos ou subsidiados, aquisição de insumos, manutenção assistencial e fortalecimento dos serviços humanitários em saúde.
Mecanismo de sustentabilidade	Descrição estratégica
Fundo Social de Saúde Humanitária	Será instituído centro de custo, conta gerencial ou mecanismo interno de rastreabilidade financeira para vincular a economia energética à oferta de serviços sociais, permitindo demonstrar quanto foi economizado, quanto foi convertido em assistência e quais resultados foram gerados.
Plano anual de conversão social da economia	A cada exercício, o iSanté poderá definir plano anual de aplicação da economia energética em metas assistenciais, como consultas, exames, retornos, acompanhamentos, mediação intercultural, materiais multilíngues e ações de proteção.
Integração progressiva com SUS e rede socioassistencial	A articulação com SUS, assistência social, CRAS, CREAS, unidades de acolhimento, organizações humanitárias e instituições que atuam com migrantes permitirá organizar fluxos de encaminhamento, contrarreferência e continuidade do cuidado, reduzindo duplicidades e ampliando a efetividade da intervenção.
Parceria acadêmica e científica com a UFAC	A integração ensino-serviço fortalecerá a continuidade da formação profissional, da pesquisa aplicada, dos estágios supervisionados e da produção de evidências sobre saúde migratória, mantendo o projeto ativo como plataforma de ensino, ciência e inovação social.
Captação contínua e diversificada	O projeto irá manter agenda anual de captação junto a editais públicos, fundos ESG, organismos internacionais, fundações corporativas, emendas parlamentares, cooperação técnica, patrocínios de impacto e parcerias com empresas comprometidas com saúde, energia limpa e desenvolvimento sustentável.
Patrocínio por carteira de serviços	Poderão ser estruturadas cotas de financiamento por serviços ou resultados, como pacote de consultas, exames laboratoriais, exames de imagem, atendimentos materno-infantis, acompanhamento de doenças crônicas, formação de estudantes ou mediação intercultural.
Relatórios ESG e evidências de impacto	A produção de relatórios periódicos, painéis de indicadores, boletins epidemiológicos, estudos de caso e avaliações de impacto permitidemonstrará resultados mensuráveis, fortalecer a confiança de financiadores e apoiar novas rodadas de investimento.
Publicação científica e disseminação institucional	A produção de artigos, relatórios técnicos, apresentações em eventos e sistematização metodológica ampliará a visibilidade do modelo e sua credibilidade perante universidades, organismos internacionais, gestores públicos e investidores de impacto.
Formação de capacidades locais	As trilhas formativas em saúde humanitária, atendimento intercultural, energia limpa, sustentabilidade hospitalar, ESG, salvaguardas e proteção de dados criarão capacidade técnica local para continuidade das ações após o financiamento inicial.
Comitê de Governança e Comitê Consultivo Comunitário	A manutenção das instâncias de governança e participação social permitirá acompanhamento dos resultados, análise de riscos, escuta dos beneficiários, correção de rotas e reforço da accountability junto à população migrante e aos parceiros.
Replicabilidade do modelo	A experiência será sistematizada como metodologia replicável para outras unidades de saúde, municípios amazônicos, territórios de fronteira e instituições interessadas em converter eficiência energética em impacto social mensurável.
Contrapartidas institucionais progressivas	O iSanté e parceiros poderão aportar estrutura física, equipe técnica, horas de trabalho, apoio acadêmico, gestão administrativa, comunicação, dados, supervisão científica e outros recursos não financeiros que fortaleçam a continuidade do projeto.
Estratégia de comunicação e posicionamento internacional	A comunicação dos resultados irá apresentar o projeto como modelo amazônico de saúde humanitária climaticamente resiliente, conectando energia limpa, saúde, proteção de migrantes, ciência aplicada e ESG, o que ampliará sua atratividade para novos financiadores.

A sustentabilidade pós-financiamento será garantida pela combinação entre economia energética recorrente, governança financeira vinculada ao impacto social, parcerias públicas, acadêmicas e humanitárias, produção de evidências, captação contínua e replicabilidade metodológica. O sistema fotovoltaico com BESS terá vida



útil de 20 anos (superior ao ciclo inicial do projeto), permitindo que a economia gerada continue apoiando a assistência humanitária para além dos 24 meses.

A infraestrutura energética permanecerá gerando economia operacional após o término do financiamento, ampliando a capacidade do iSanté de manter atendimentos gratuitos ou subsidiados, mobilizar novas parcerias e demonstrar resultados de longo prazo em saúde, clima e proteção humanitária.

Dessa forma, o projeto não se encerra com o financiamento inicial. O aporte externo funciona como investimento estruturante para criar uma plataforma permanente de saúde humanitária sustentável no Acre, ampliando o acesso de migrantes e refugiados à assistência médica, fortalecendo a resiliência energética hospitalar, produzindo conhecimento científico e consolidando um modelo ESG replicável para territórios amazônicos e fronteiriços.

20. PLANO DE REPLICABILIDADE E ESCALA

O Projeto Amazônia Sem Fronteiras será desenvolvido como piloto estruturante e vitrine de investimento de impacto para demonstrar que hospitais, institutos de saúde e organizações assistenciais localizadas em territórios amazônicos, fronteiriços e de alta vulnerabilidade social podem utilizar energia limpa como motor de sustentabilidade financeira, ampliação do acesso à saúde, fortalecimento da proteção humanitária e produção de evidências aplicadas.

A replicabilidade do modelo não dependerá apenas da instalação de um sistema fotovoltaico. O diferencial do projeto está na combinação entre infraestrutura energética sustentável, conversão da economia em atendimento gratuito, protocolo intercultural de saúde migratória, salvaguardas, formação profissional, pesquisa aplicada, governança ESG e prestação de contas mensurável. Portanto, a escala do projeto exigirá sistematização técnica, metodológica, financeira e institucional, permitindo que a experiência do Acre seja adaptada a outros hospitais, municípios de fronteira, unidades de saúde filantrópicas, organizações sociais e territórios amazônicos com desafios semelhantes.

O plano de replicabilidade será construído ao longo dos 24 meses de execução, com base nos aprendizados gerados pela implantação energética, pelo atendimento direto aos migrantes e refugiados, pela validação participativa da Teoria da Mudança, pela atuação dos comitês de governança, pelos indicadores ESG e pelos resultados científicos produzidos.



Produto de replicabilidade	Conteúdo estratégico	Finalidade
Manual do Modelo ESG em Saúde Humanitária	Descrição da Teoria da Mudança, linha de base, lógica de intervenção, critérios de elegibilidade, governança ESG, fluxo assistencial, salvaguardas, matriz de indicadores e mecanismos de accountability.	Permitir que outras instituições compreendam e adaptem o modelo completo, e não apenas a dimensão energética.
Kit Técnico Energético	Parâmetros mínimos para estudo de viabilidade, análise de faturas, curva de carga, dimensionamento fotovoltaico, BESS, operação zero grid, homologação, manutenção, monitoramento e cálculo de economia.	Apoiar a avaliação técnica e financeira de sistemas de energia limpa em outras unidades de saúde.
Modelo Financeiro de Conversão Social da Economia	Metodologia para calcular economia energética, criar centro de custo, vincular recursos economizados a atendimentos gratuitos e demonstrar custo por beneficiário, consulta, exame ou serviço ofertado.	Demonstrar como a economia gerada pela energia limpa pode ser transformada em impacto social mensurável.
Protocolo Assistencial Humanitário Intercultural	Fluxo de acolhimento, cadastro, triagem socioassistencial, avaliação clínica, priorização, mediação linguística, materiais multilíngues, encaminhamentos e acompanhamento terapêutico.	Padronizar o atendimento de migrantes e refugiados com dignidade, segurança clínica e respeito às diferenças culturais e linguísticas.
Política Salvaguardas Proteção	Proteção infantil, gênero, prevenção de exploração e abuso sexual, não discriminação, LGPD, consentimento informado, ética em pesquisa, canal de denúncia e fluxo de encaminhamento de riscos.	Assegurar que a replicação observe padrões mínimos de proteção exigidos por financiadores internacionais.
Matriz Indicadores Avaliação Impacto	Indicadores com baseline, meta anual, meta total, fórmula de cálculo, periodicidade, fonte de dados, responsável e evidência documental.	Garantir mensuração padronizada, comparabilidade entre territórios e prestação de contas baseada em evidências.
Modelo Prestação Contas ESG	Estrutura de relatório ESG, dashboard de indicadores, evidências documentais, matriz de rastreabilidade financeira, plano de auditoria e comunicação de resultados.	Fortalecer transparência, accountability e confiança de financiadores, parceiros e beneficiários.
Plano de Formação e Capacitação	Trilhas formativas em saúde humanitária, atendimento intercultural, energia limpa, sustentabilidade hospitalar, ODS, ESG, proteção de dados e salvaguardas.	Criar capacidades locais para continuidade e adaptação do modelo em diferentes contextos.
Guia de Participação Social e Comitê Consultivo	Orientações para criação de comitê consultivo com instituições que atuam com migrantes, rede pública, assistência social, estudantes e representantes dos beneficiários quando possível.	Garantir escuta ativa, adequação cultural e accountability junto às populações afetadas.
Plano de Comunicação e Disseminação	Estudos de caso, relatórios executivos, infográficos, vídeos institucionais, publicações científicas, apresentações técnicas e materiais para investidores.	Ampliar visibilidade, atrair novos financiadores e apoiar a expansão do modelo para outros territórios.

20.1. Estratégia de escala

A expansão do modelo ocorrerá de forma progressiva e responsável, evitando replicação automática sem análise territorial. Cada nova unidade ou território interessado deverá realizar diagnóstico mínimo de viabilidade, contemplando fluxo migratório ou vulnerabilidade social relevante, demanda reprimida em saúde, capacidade assistencial instalada, consumo energético, potencial de economia, rede de parceiros, salvaguardas e capacidade de governança.

A escala poderá seguir três caminhos complementares:



Modalidade de escala	Descrição
Escala institucional	Expansão do modelo dentro do próprio ecossistema iSanté e Hospital Silvestre Santé, ampliando serviços, especialidades, formação e produção científica.
Escala territorial	Adaptação do modelo para outros municípios acreanos ou amazônicos com fluxo migratório, vulnerabilidade social, baixa oferta de especialidades e pressão sobre a rede pública.
Escala metodológica	Disseminação do manual, protocolos, matriz de indicadores e modelo financeiro para outras instituições de saúde, organizações sociais, hospitais filantrópicos e parceiros ESG.

Para que o modelo seja replicado com segurança técnica, ética e financeira, recomenda-se que cada nova experiência observe as seguintes condições mínimas:

Condição	Justificativa
Diagnóstico territorial e linha de base	A replicação deve partir de dados concretos sobre população vulnerável, demanda em saúde e capacidade institucional local.
Estudo de viabilidade energética	A implantação de energia limpa deve ser sustentada por análise de faturas, curva de carga, potencial de geração, custo de implantação, economia projetada e manutenção.
Capacidade assistencial instalada	A unidade replicadora precisa demonstrar capacidade mínima para ofertar consultas, exames, acolhimento, encaminhamentos e acompanhamento.
Governança e rastreabilidade financeira	A economia energética deve ser monitorada e vinculada formalmente à finalidade social, evitando perda de transparência.
Salvaguardas formalizadas	A replicação deve incluir proteção infantil, gênero, LGPD, consentimento, não discriminação, canal de denúncia e fluxo de proteção.
Protocolo intercultural	Em territórios com migrantes, indígenas, ribeirinhos ou outras populações culturalmente diversas, o atendimento deve prever mediação cultural e comunicação acessível.
Parcerias locais	A sustentabilidade depende de articulação com SUS, assistência social, universidades, organizações humanitárias, gestores públicos e financiadores locais.
Sistema de indicadores	Sem indicadores padronizados, não será possível demonstrar impacto, comparar resultados ou atrair novos investimentos.

Ao final dos 24 meses, o projeto irá entregar uma metodologia validada, documentada e pronta para adaptação em outros contextos. O resultado esperado é consolidar o Modelo Amazônia Sem Fronteiras de Saúde Humanitária Sustentável, demonstrando que a economia gerada por energia limpa pode financiar assistência médica gratuita, qualificar o cuidado a populações vulneráveis, fortalecer a formação profissional, produzir evidências científicas e gerar impacto ESG auditável.



Dessa forma, o projeto deixará como legado não apenas os atendimentos realizados no Acre, mas uma tecnologia social replicável para territórios amazônicos e fronteiriços, capaz de articular saúde, energia, proteção, ciência e governança em uma solução concreta de desenvolvimento sustentável.

21. PLANO DE COMUNICAÇÃO E VISIBILIDADE PARA INVESTIDORES

O Plano de Comunicação e Visibilidade do Projeto Amazônia Sem Fronteiras será orientado por três princípios centrais: impacto mensurável, transparência na aplicação dos recursos e dignidade dos beneficiários. A comunicação não terá caráter meramente promocional; sua finalidade será demonstrar, de forma clara e verificável, que o investimento realizado gera resultados concretos em saúde humanitária, energia limpa, proteção social, formação profissional, pesquisa aplicada e governança ESG no Estado do Acre.

A estratégia de comunicação irá posicionar o projeto como uma iniciativa inovadora e replicável, capaz de transformar economia energética em assistência médica gratuita para migrantes e refugiados em situação de vulnerabilidade. Para potenciais investidores, a narrativa irá evidenciar a relação direta entre o recurso aportado, a infraestrutura implantada, a economia gerada, os atendimentos realizados, os dados produzidos e o legado institucional construído ao longo dos 24 meses.

A comunicação também irá observar critérios éticos rigorosos, especialmente por envolver populações vulneráveis. O uso de imagens, depoimentos, histórias de vida ou estudos de caso dependerá de consentimento livre, esclarecido e específico, com proteção da identidade quando necessário. Nenhum material irá expor indevidamente migrantes, crianças, adolescentes, pessoas em situação documental frágil, vítimas de violência, pessoas com sofrimento psíquico ou indivíduos em condição de risco social. O projeto irá comunicar impacto sem explorar vulnerabilidade.

A comunicação institucional do projeto será sustentada por uma mensagem simples, forte e recorrente: “O Amazônia Sem Fronteiras transforma energia limpa em saúde humanitária, convertendo economia operacional em atendimento médico gratuito, produção científica, formação profissional e proteção social para migrantes e refugiados vulneráveis no Acre.” Essa narrativa deverá evidenciar ao investidor que o aporte financeiro não financia apenas equipamentos ou custeio assistencial; financia uma plataforma de impacto social mensurável, com legado energético, humanitário, científico e institucional para a Amazônia.

Enfim, o projeto entregará uma narrativa institucional qualificada, apoiada por dados, relatórios, evidências fotográficas, éticas, indicadores de impacto e materiais executivos que demonstrem como o investimento se converteu em saúde, proteção, energia limpa, conhecimento e capacidade instalada na Amazônia.



21.1. Produtos de Comunicação e Prestação de Contas

Produto de comunicação	Periodicidade	Finalidade
Relatório técnico trimestral	Trimestral	Acompanhar execução física, financeira, assistencial, energética, acadêmica e de salvaguardas.
Relatório anual ESG e impacto	Anual	Prestar contas a financiadores, parceiros, comunidade e sociedade, consolidando indicadores sociais, ambientais, assistenciais, científicos e de governança.
Dashboard sintético de indicadores	Trimestral	Visualizar energia gerada, economia financeira, valor convertido em assistência, pessoas atendidas, consultas, exames, mediações interculturais e resultados sociais.
Boletim de saúde migratória	Anual	Sistematizar dados agregados sobre perfil dos beneficiários, principais demandas de saúde, barreiras de acesso e aprendizados assistenciais.
Estudos de caso protegidos	Semestral	Humanizar os resultados sem expor indevidamente os beneficiários, utilizando anonimização, consentimento e linguagem ética.
Vídeo institucional de impacto	Anual	Apresentar a tese do projeto, os resultados alcançados, o papel dos investidores e o legado territorial para novas rodadas de captação.
Brief executivo para investidores	Sob demanda e atualização semestral	Apoiar reuniões estratégicas, prospecção de financiadores, emendas, editais, fundações corporativas e organismos internacionais.
Versão curta do projeto, 2 páginas	Atualização semestral	Apresentar problema, solução, orçamento, impacto, indicadores e oportunidade de investimento em formato objetivo.
Infográficos de impacto	Trimestral ou semestral	Traduzir dados complexos em peças visuais sobre fluxo migratório, energia limpa, atendimentos, economia convertida e resultados humanitários.
Notas institucionais e releases	Conforme marcos relevantes	Divulgar marcos do projeto, como implantação do sistema energético, início dos atendimentos, relatórios anuais, parcerias e resultados relevantes.
Dossiê de evidências para financiadores	Atualização anual	Reunir contratos, relatórios, fotos, indicadores, auditorias, publicações, atas, documentos técnicos e evidências de execução.

22. MATRIZ DE RISCOS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

A gestão de riscos do Projeto Amazônia Sem Fronteiras será conduzida de forma preventiva, contínua e documentada, com foco na proteção dos beneficiários, na segurança assistencial, na integridade dos dados, na execução física e financeira, na operação energética, na governança ESG e na sustentabilidade pós-financiamento.

Para fins de qualificação da proposta, a matriz de riscos irá identificar não apenas a probabilidade, o impacto e a mitigação, mas também o proprietário do risco, o gatilho de alerta, o plano de resposta, o custo estimado de mitigação e o status de acompanhamento. Essa estrutura fortalece a governança, evita riscos sem responsável definido e permite demonstrar capacidade institucional de antecipação, resposta e correção de rota.

A matriz irá ser revisada periodicamente pelo Comitê de Governança ESG, com participação da coordenação assistencial, coordenação científica, coordenação de proteção, equipe financeira, integradora energética e Comitê Consultivo



Comunitário, quando o risco envolver acesso, proteção, barreiras culturais ou feedback dos beneficiários.



22.1. Matriz Quantitativa de Riscos

Risco	Probabilidade	Impacto	Nível do risco	Proprietário do risco	Gatilho de alerta	Plano de resposta e mitigação	Custo de mitigação	Status
Aumento súbito da demanda migratória	Alta	Alto	Crítico	Coordenação Geral e Coordenação Assistencial	Crescimento abrupto da procura, aumento de encaminhamentos pela rede parceira ou chegada de novo fluxo migratório ao Acre.	Aplicar protocolo de priorização, teto mensal de capacidade, triagem por risco social e clínico, agenda de contingência e articulação com SUS, assistência social e organizações humanitárias.	Baixo a médio, associado à ampliação de agendas, horas técnicas e mediação.	Em monitoramento contínuo.
Sobrecarga assistencial da unidade executora	Média	Alto	Alto	Coordenação Assistencial	Aumento de fila interna, atrasos em consultas, exames ou retornos, queda da resolatividade ou excesso de demanda sobre equipe médica.	Escalonar atendimentos por fases, aplicar critérios de elegibilidade e priorização, monitorar fila interna, ampliar dias de atendimento quando possível e pactuar fluxos de encaminhamento com a rede pública.	Médio, conforme necessidade de horas profissionais adicionais.	A monitorar após início dos atendimentos.
Barreiras linguísticas e culturais	Alta	Médio	Alto	Coordenação Assistencial e Mediador Cultural	Beneficiário com baixa compreensão do português, dificuldade de consentimento, falha de adesão ao tratamento ou incompreensão de orientações clínicas.	Implantar protocolo intercultural multilíngue, materiais em português, espanhol, francês e/ou crioulo haitiano quando aplicável, registro de idioma, acionamento de mediador cultural e capacitação da equipe.	Médio, relacionado a mediação, tradução e produção de materiais.	Previsto no desenho metodológico.
Ausência ou fragilidade documental dos beneficiários	Alta	Médio	Alto	Coordenação de Proteção e Acolhimento	Beneficiário sem documento civil, migratório, CPF, Cartão SUS ou comprovante de residência.	Criar registro provisório interno, permitir acolhimento e triagem sem impedimento documental, preservar confidencialidade e articular encaminhamento à rede de documentação quando aplicável.	Baixo, associado à adequação de formulários e fluxo de cadastro.	Previsto nos critérios de elegibilidade.
Exclusão involuntária de grupos vulneráveis	Média	Alto	Alto	Coordenação de Proteção e Comitê Consultivo Comunitário	Baixa participação de mulheres, crianças, gestantes, idosos, pessoas com deficiência, haitianos, senegaleses ou pessoas com barreira linguística.	Monitorar dados desagregados por sexo, idade, nacionalidade, idioma e vulnerabilidade; ajustar busca ativa, mediação cultural, materiais e fluxos de acolhimento.	Baixo a médio, conforme necessidade de comunicação e articulação territorial.	A monitorar com indicadores.
Falha na validação participativa da Teoria da Mudança	Média	Médio	Moderado	Coordenação ESG e Comitê Consultivo Comunitário	Baixa adesão de parceiros, ausência de beneficiários na escuta ou protocolos construídos sem evidência de participação.	Planejar oficinas e escutas comunitárias, envolver rede migratória, SUS, assistência social, estudantes e representantes dos beneficiários quando possível; registrar atas e recomendações.	Baixo a médio, relacionado à mobilização e facilitação.	Previsto antes da implantação definitiva dos protocolos.
Divergência técnica entre memorial, BESS, inversores ou módulos	Média	Alto	Alto	Coordenação Energética e Empresa Integradora	Incompatibilidade entre capacidade prevista, datasheets, orçamento, memorial técnico, homologação ou requisitos da concessionária.	Realizar revisão técnica antes da compra, compatibilizar modelos, validar memorial, emitir ART, revisar datasheets, certificações e dimensionamento final.	Médio, associado à consultoria técnica e eventuais ajustes de projeto.	Deve ser resolvido antes da contratação final.



Risco	Probabilidade	Impacto	Nível do risco	Proprietário do risco	Gatilho de alerta	Plano de resposta e mitigação	Custo de mitigação	Status
Atraso na aquisição, instalação ou homologação energética	Média	Médio	Moderado	Coordenação Energética e Empresa Integradora	Demora em entrega de equipamentos, pendência documental, exigência adicional da concessionária ou atraso de homologação.	Inserir cronograma regulatório, acompanhar concessionária, prever margem temporal, manter documentação técnica completa e contratar integradora com experiência comprovada.	Médio, podendo impactar cronograma e custos indiretos.	A monitorar no Ano 1.
Desempenho energético inferior ao projetado	Média	Alto	Alto	Coordenação ESG e Empresa Integradora	Geração mensal abaixo da premissa conservadora, falhas recorrentes, baixa disponibilidade do sistema ou economia menor que a estimada.	Monitorar dashboard energético, estabelecer contrato de operação e manutenção, revisar curva de carga, realizar manutenção preventiva e ajustar plano de conversão social conforme economia efetiva.	Médio, relacionado a O&M, monitoramento e ajustes técnicos.	A monitorar após implantação.
Falha técnica no BESS ou indisponibilidade de suporte	Baixa a média	Alto	Alto	Empresa Integradora e Coordenação Energética	Alarmes técnicos, redução de ciclos, falha no deslocamento de consumo de ponta ou interrupções operacionais.	Contrato de manutenção preventiva e corretiva, garantia técnica, suporte remoto, plano de contingência energética e treinamento mínimo da equipe local.	Médio a alto, conforme garantia e contrato de O&M.	A definir em contrato.
Oscilação cambial e aumento do custo de equipamentos	Média	Médio	Moderado	Coordenação Financeira e Coordenação Energética	Varição relevante em cotações, vencimento de propostas, aumento de frete, impostos ou indisponibilidade de equipamentos.	Atualizar cotações antes da submissão, prever validade comercial, reserva técnica, alternativas equivalentes certificadas e planejamento de compras por marcos.	Médio, podendo exigir reserva de contingência.	Em monitoramento até contratação.
Risco de dados sensíveis e violação da LGPD	Média	Alto	Alto	Coordenação de Proteção de Dados e Coordenação Científica	Acesso indevido a prontuários, exposição de dados migratórios, compartilhamento não autorizado ou uso inadequado de informações de saúde.	Implantar política de proteção de dados, matriz de acesso, termos de confidencialidade, consentimento informado, anonimização, pseudonimização e auditoria periódica.	Médio, associado à capacitação, sistemas e controles internos.	Deve ser implementado antes dos atendimentos.
Uso científico de dados sem aprovação ética adequada	Baixa a média	Alto	Alto	Coordenação Científica e UFAC	Pesquisa com prontuários, entrevistas, acompanhamento longitudinal ou dados sensíveis sem submissão ao CEP quando aplicável.	Submeter protocolos ao Comitê de Ética em Pesquisa, aplicar TCLE quando necessário, anonimizar dados e adotar plano de publicação responsável.	Baixo a médio, relacionado à gestão científica e documentação.	Obrigatório antes das pesquisas aplicáveis.
Exposição indevida de beneficiários em comunicação pública	Baixa	Alto	Moderado	Coordenação de Comunicação e Coordenação de Proteção	Uso de imagem, nome, nacionalidade, história de vida ou condição migratória sem consentimento específico ou com risco de estigmatização.	Implantar política de imagem e comunicação ética, consentimento específico, anonimização, revisão ética de materiais e proteção especial para crianças e vítimas de violência.	Baixo, associado a revisão, termos e capacitação.	Deve ser implementado antes da divulgação.



Risco	Probabilidade	Impacto	Nível do risco	Proprietário do risco	Gatilho de alerta	Plano de resposta e mitigação	Custo de mitigação	Status
Ocorrência de violência, exploração, abuso, assédio ou conduta antiética	Baixa a média	Alto	Alto	Coordenação de Proteção e Coordenação Geral	Denúncia, relato de beneficiário, comportamento inadequado da equipe, troca indevida de benefício por atendimento ou violação de conduta.	Implantar política PSEA, código de conduta, canal de denúncia, fluxo de apuração, medidas de proteção, capacitação obrigatória e resposta institucional documentada.	Médio, conforme necessidade de apuração, capacitação e apoio à vítima.	Deve ser formalizado antes da execução assistencial.
Falha em comprovar impacto social e ESG	Média	Alto	Alto	Coordenação ESG e Coordenação Geral	Indicadores incompletos, ausência de baseline, baixa qualidade de evidências, relatórios frágeis ou inconsistência entre metas e execução.	Implantar matriz lógica, matriz de indicadores SMART, dashboard, fontes de verificação, auditoria ou revisão externa, relatórios técnicos e ESG periódicos.	Médio, associado a sistema de monitoramento e revisão externa.	Em estruturação.
Baixa qualidade ou inconsistência dos registros assistenciais	Média	Alto	Alto	Coordenação Assistencial	Prontuários incompletos, ausência de desfecho, não registro de idioma, nacionalidade, retorno, mediação ou encaminhamento.	Padronizar formulários, treinar equipe, revisar amostras de prontuários, criar campos obrigatórios e estabelecer rotina mensal de qualidade de dados.	Baixo a médio, relacionado à capacitação e gestão de dados.	A implementar antes do início dos atendimentos.
Descontinuidade de financiamento após o ciclo inicial	Média	Alto	Alto	Coordenação Geral e Coordenação de Captação	Encerramento do financiamento principal, ausência de novas fontes, queda na capacidade de atendimento ou suspensão de serviços sociais.	Estruturar fundo social, plano de conversão da economia energética, captação contínua, parcerias ESG, editais, emendas, cooperação internacional e patrocínio por carteira de serviços.	Médio, relacionado à captação e comunicação institucional.	A iniciar desde o Ano 1.
Baixa adesão dos beneficiários aos retornos e acompanhamentos	Média	Médio	Moderado	Coordenação Assistencial e Mediador Cultural	Faltas recorrentes, perda de contato, mobilidade territorial, dificuldade de comunicação ou não compreensão do plano terapêutico.	Cartão de retorno multilíngue, confirmação por telefone ou rede parceira, mediação cultural, busca ativa protegida e orientação clara sobre continuidade do cuidado.	Baixo a médio, conforme estratégia de comunicação.	A monitorar durante execução.
Fragilidade da rede de encaminhamento e contrarreferência	Média	Alto	Alto	Coordenação de Proteção e Coordenação Assistencial	Encaminhamentos sem retorno, dificuldade de acesso ao SUS, assistência social ou rede de proteção, ausência de ponto focal parceiro.	Formalizar matriz da rede parceira, criar fluxos de encaminhamento, registrar contrarreferências, realizar reuniões periódicas com SUS, CRAS, CREAS, unidades de acolhimento e organizações humanitárias.	Baixo a médio, associado à articulação institucional.	Em construção com governança.
Rotatividade de profissionais, estudantes ou mediadores	Média	Médio	Moderado	Coordenação Geral, Assistencial e Acadêmica	Troca frequente de equipe, perda de conhecimento, atrasos em atendimento ou falhas na aplicação dos protocolos.	Criar manual operacional, trilhas de capacitação contínua, banco de profissionais, integração periódica e supervisão técnica.	Médio, conforme necessidade de reposição e treinamento.	A monitorar semestralmente.



Risco	Probabilidade	Impacto	Nível do risco	Proprietário do risco	Gatilho de alerta	Plano de resposta e mitigação	Custo de mitigação	Status
Baixa participação do Comitê Consultivo Comunitário	Média	Médio	Moderado	Coordenação ESG	Reuniões esvaziadas, ausência de instituições migratórias, baixa participação de beneficiários ou falta de resposta às recomendações.	Definir calendário, convites formais, pauta objetiva, registro de recomendações, devolutiva institucional e alternativas de escuta protegida.	Baixo, associado à mobilização.	A implementar após constituição do comitê.
Risco reputacional para financiadores e parceiros	Baixa a média	Alto	Alto	Coordenação Geral e Comunicação	Falhas de prestação de contas, exposição indevida, denúncia pública, inconsistência de dados ou baixa transparência.	Comunicação ética, relatórios periódicos, auditoria, revisão de dados, comitê de governança, canal de denúncia e resposta rápida a incidentes.	Médio, conforme nível de revisão externa e comunicação.	Em monitoramento contínuo.
Eventos climáticos extremos ou instabilidade territorial	Média	Médio a alto	Alto	Coordenação Geral e Coordenação Assistencial	Enchentes, eventos climáticos severos, dificuldade de acesso, aumento de doenças ou interrupção de serviços.	Plano de contingência operacional, priorização de atendimentos, articulação com Defesa Civil, SUS e assistência social, e revisão temporária das agendas.	Médio, conforme necessidade de resposta emergencial.	A incorporar ao plano de contingência.
Risco sanitário ou epidemiológico emergente	Média	Alto	Alto	Coordenação Assistencial e Científica	Aumento de casos de agravos transmissíveis, surtos, sintomas recorrentes em grupos atendidos ou alerta da vigilância epidemiológica.	Protocolos de triagem, notificação quando aplicável, articulação com vigilância, proteção da equipe, orientação aos beneficiários e produção de boletins epidemiológicos.	Médio, conforme necessidade de insumos e fluxos específicos.	A monitorar com indicadores de saúde.



22.2 Escala de Classificação dos Riscos

Classificação	Critério estabelecido
Probabilidade baixa	Evento pouco provável, com ocorrência excepcional ou dependente de fatores externos específicos.
Probabilidade média	Evento possível durante a execução, exigindo monitoramento preventivo.
Probabilidade alta	Evento provável ou já identificado como recorrente no contexto territorial ou operacional.
Impacto baixo	Afeta pontualmente a execução, sem comprometer metas centrais.
Impacto médio	Pode gerar atrasos, custos adicionais ou necessidade de ajustes operacionais.
Impacto alto	Pode comprometer segurança, reputação, continuidade, metas, beneficiários ou prestação de contas.

22.3 Rotina de Monitoramento e Governança dos Riscos

A matriz de riscos irá ser atualizada, no mínimo, trimestralmente pelo Comitê de Governança ESG, com registro de alterações, novos riscos identificados, medidas adotadas, responsáveis e status de cada item. Riscos classificados como altos ou críticos irão gerar plano de ação específico, com prazo, responsável, evidência de mitigação e comunicação à coordenação geral.

Rotina	Responsável	Periodicidade	Evidência
Atualização da matriz de riscos	Coordenação ESG	Trimestral	Matriz revisada e ata do comitê
Revisão dos riscos assistenciais	Coordenação Assistencial	Mensal	Relatório assistencial e plano corretivo
Revisão dos riscos de proteção	Coordenação de Proteção	Mensal ou por ocorrência	Registro de casos, encaminhamentos e providências
Revisão dos riscos energéticos	Empresa Integradora e Coordenação ESG	Mensal após implantação	Dashboard energético e relatório técnico
Revisão dos riscos financeiros	Coordenação Financeira	Mensal	Relatório financeiro e cronograma de desembolso
Revisão dos riscos científicos e de dados	Coordenação Científica e Proteção de Dados	Trimestral	Relatório de pesquisa, CEP e controle de dados
Comunicação de riscos críticos	Coordenação Geral	Imediata, quando necessário	Comunicado interno, ata extraordinária ou relatório ao financiador



23. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO PARA ORGANISMOS INTERNACIONAIS

O Projeto Amazônia Sem Fronteiras representa uma resposta integrada, territorialmente fundamentada e orientada por direitos, voltada à ampliação do acesso à saúde de migrantes, refugiados e pessoas em mobilidade internacional em situação de vulnerabilidade no Estado do Acre. A proposta dialoga diretamente com agendas globais de proteção humanitária, redução das desigualdades, saúde e bem-estar, energia limpa, resiliência climática de serviços essenciais, produção de evidências e fortalecimento de parcerias institucionais.

Como demonstrado no quadro a seguir, essa iniciativa responde ao princípio de não deixar ninguém para trás, ao estruturar um modelo que combina assistência médica gratuita, protocolos interculturais, salvaguardas, participação social, pesquisa aplicada, formação profissional, governança ESG e sustentabilidade financeira baseada em energia limpa:

Critério ONU	Como a proposta responde
Relevância humanitária	O projeto atua em território de fronteira internacional, onde o Acre registrou fluxo migratório expressivo entre 2015 e 2026, com migrantes e refugiados em situação de vulnerabilidade social, sanitária, econômica, linguística e documental.
Princípio de não deixar ninguém para trás	A proposta prioriza populações deslocadas e grupos com maior risco de exclusão no acesso à saúde, especialmente mulheres, crianças, gestantes, idosos, pessoas com deficiência, pessoas com doenças crônicas, pessoas indocumentadas e pessoas com barreiras linguísticas.
Equidade e inclusão	O modelo prevê acolhimento humanizado, triagem socioassistencial e clínica, atendimento intercultural e acesso gratuito a consultas, exames, retornos e encaminhamentos.
Proteção humanitária	O projeto incorpora salvaguardas para proteção infantil, gênero, prevenção de exploração e abuso sexual, não discriminação, consentimento informado, confidencialidade e fluxo de encaminhamento para casos de violência ou risco social.
Accountability to affected populations	A proposta prevê validação participativa da Teoria da Mudança, Comitê Consultivo Comunitário, escuta de beneficiários, canal de feedback e adequação dos protocolos às barreiras reais de acesso.
Coordenação interinstitucional	O projeto será executado pelo iSanté em cooperação com o Hospital Silvestre Santé e a UFAC, com articulação com SUS, assistência social, organizações humanitárias, unidades de acolhimento e rede migratória.
ODS e Agenda 2030	A proposta contribui para ODS 3, 4, 7, 10, 13, 16 e 17, ao integrar saúde, educação, energia limpa, redução das desigualdades, ação climática, instituições eficazes e parcerias.
Sustentabilidade e resiliência climática	A implantação do sistema fotovoltaico com BESS reduz custos operacionais, fortalece a segurança energética hospitalar e cria base recorrente de financiamento social.
Evidência, dados e aprendizagem	A proposta produzirá dados epidemiológicos, relatórios técnicos, boletins de saúde migratória, pesquisas aplicadas e publicações científicas.
Transparência e prestação de contas	O projeto prevê governança ESG, relatórios periódicos, painel de indicadores, auditoria ou revisão externa, matriz de riscos e prestação de contas financeira, técnica e social.

O projeto não se limita à prestação de serviços assistenciais pontuais; propõe uma plataforma replicável de saúde humanitária sustentável em território amazônico e fronteiriço.

Essa proposta oferece uma combinação rara entre urgência humanitária, inovação climática, capacidade de execução local e mecanismos verificáveis de accountability; permitindo demonstrar, em escala territorial concreta, como



investimentos em energia limpa podem fortalecer serviços essenciais de saúde e proteger populações deslocadas em contexto amazônico de fronteira.

O alinhamento com organismos internacionais, se destaca em seis elementos centrais: a evidência territorial do fluxo migratório no Acre, a priorização de grupos vulneráveis, a proteção de beneficiários, a integração com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a sustentabilidade pós-financiamento e os mecanismos de accountability junto às populações afetadas.



23.1. Matriz de Alinhamento com os ODS

ODS	Contribuição do projeto	Indicadores relacionados	Evidências previstas no projeto
ODS 3, Saúde e Bem-Estar	Ampliação do acesso gratuito à assistência médica, consultas, exames, urgências, retornos e acompanhamento para migrantes e refugiados vulneráveis.	Beneficiários únicos atendidos; consultas realizadas; exames laboratoriais; exames de imagem; retornos; urgências; desfechos com orientação ou encaminhamento.	Prontuários, fichas de atendimento, laudos, relatórios assistenciais e painel de indicadores.
ODS 4, Educação de Qualidade	Formação de estudantes, profissionais e equipes em saúde humanitária, atendimento intercultural, sustentabilidade hospitalar, salvaguardas e ESG aplicado à saúde.	Pessoas capacitadas; horas de formação; trilhas formativas; estudantes em prática supervisionada; certificados emitidos.	Listas de presença, certificados, planos de curso, relatórios acadêmicos e materiais formativos.
ODS 7, Energia Limpa e Acessível	Implantação de sistema solar fotovoltaico com BESS, reduzindo custos energéticos e fortalecendo a sustentabilidade operacional da unidade de saúde.	kWh gerados; economia financeira; percentual de redução da fatura; disponibilidade do sistema; desempenho do BESS.	Faturas, dashboard energético, relatórios técnicos, ART, homologação e relatórios de operação.
ODS 10, Redução das Desigualdades	Priorização de migrantes e refugiados em situação de vulnerabilidade, com critérios de elegibilidade, atendimento intercultural e acesso gratuito a serviços de saúde.	Beneficiários por nacionalidade, sexo, idade, idioma e grupo prioritário; atendimentos com mediação cultural; encaminhamentos à rede parceira.	Fichas de triagem, registros de mediação, relatórios de vulnerabilidade e relatórios ESG.
ODS 13, Ação Climática	Promoção de resiliência climática e energética em serviço essencial de saúde, com redução de emissões e menor dependência de energia convencional.	Emissões de CO ₂ equivalente evitadas; energia limpa gerada; economia energética acumulada; desempenho ambiental do sistema.	Relatórios ambientais, memória de cálculo, metodologia de fator de emissão e dashboard energético.
ODS 16, Paz, Justiça e Instituições Eficazes	Fortalecimento de governança, salvaguardas, proteção de dados, canal de denúncia, ética em pesquisa, transparência e accountability.	Políticas de salvaguardas implantadas; manifestações recebidas e tratadas; riscos monitorados; reuniões de comitê; relatórios publicados.	Código de conduta, política PSEA, política LGPD, atas, relatórios de proteção, matriz de riscos e canal de feedback.
ODS 17, Parcerias e Meios de Implementação	Articulação entre iSanté, Hospital Silvestre Santé, UFAC, SUS, assistência social, organizações humanitárias, financiadores ESG e rede migratória.	Parcerias formalizadas; reuniões interinstitucionais; encaminhamentos realizados; contrarreferências; participação do Comitê Consultivo.	Termos de cooperação, cartas de apoio, atas, matriz da rede parceira e relatórios de encaminhamento.



O Projeto Amazônia Sem Fronteiras apresenta aderência estratégica às prioridades do Sistema ONU por responder, de forma integrada e baseada em evidências, a um desafio humanitário concreto em território amazônico de fronteira internacional. A proposta combina acesso à saúde, proteção de populações deslocadas, redução de desigualdades, energia limpa, resiliência climática, participação social, produção de conhecimento e governança transparente.

Sua principal força está em transformar eficiência energética em assistência médica gratuita e sustentável para migrantes e refugiados, com protocolos interculturais, salvaguardas formais, dados desagregados, indicadores verificáveis e mecanismos de accountability.

24. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO COM PARCEIROS DE ENERGIA

Para parceiros do setor energético, o projeto cria uma vitrine de alto valor reputacional: a tecnologia deixa de ser apresentada apenas como solução de eficiência e passa a ser demonstrada como infraestrutura social crítica. Cada kWh gerado, cada real economizado e cada atendimento financiado pela economia energética poderá ser comunicado como evidência concreta de que a transição energética pode salvar recursos, ampliar cuidado e proteger vidas em territórios vulneráveis.

Para os potenciais parceiros corporativos do setor energético, o Projeto Amazônia Sem Fronteiras se apresenta como uma vitrine concreta de energia limpa aplicada à saúde humanitária, propondo que a transição energética ultrapasse a dimensão ambiental e produza impacto social direto, mensurável e reputacionalmente relevante.

A tese estratégica do projeto é que a energia renovável, quando integrada a serviços essenciais de saúde, não apenas reduz custos operacionais e emissões, mas cria capacidade institucional para ampliar o acesso gratuito à assistência médica de populações vulneráveis. No caso do Acre, essa lógica ganha especial relevância por se tratar de território amazônico, de fronteira internacional, com fluxo migratório expressivo e oferta limitada de especialidades médicas.

O projeto propõe a implantação de um sistema solar fotovoltaico de 404,46 kWp, associado a um sistema de armazenamento energético por baterias, com monitoramento inteligente e conversão da economia operacional em consultas, exames, atendimentos ambulatoriais e suporte hospitalar para migrantes e refugiados. Assim, o investimento em energia limpa passará a funcionar como infraestrutura crítica de saúde, mecanismo de sustentabilidade financeira e plataforma ESG replicável para outros territórios amazônicos e fronteiriços.



Agenda do parceiro de energia	Aderência do projeto	Ações estratégicas a serem adotadas
Energia limpa para serviços essenciais	O sistema fotovoltaico associado ao BESS reduz custos, amplia previsibilidade operacional e fortalece a segurança energética de uma unidade hospitalar.	Posicionar o Hospital Silvestre Santé como infraestrutura crítica de saúde em território amazônico e fronteiriço, demonstrando que energia limpa sustenta serviços essenciais.
Acesso à energia com impacto social	A economia energética será convertida em atendimentos gratuitos para migrantes e refugiados vulneráveis.	Criar mecanismo formal de rastreabilidade financeira, demonstrando quanto foi economizado, quanto foi convertido em saúde e quais serviços foram financiados.
Inovação tecnológica	A proposta integra geração solar, BESS, operação orientada à eficiência energética e monitoramento inteligente.	Apresentar dashboard integrado de energia e impacto social, reunindo kWh gerados, economia financeira, emissões evitadas, atendimentos realizados e beneficiários alcançados.
Sustentabilidade hospitalar	O projeto reduz a exposição do hospital a custos energéticos elevados e melhora a resiliência operacional.	Demonstrar a energia limpa como estratégia de sustentabilidade de longo prazo para serviços de saúde na Amazônia.
Formação e futuro sustentável	A cooperação com a UFAC permite integrar estudantes, profissionais e jovens em atividades de formação.	Criar trilha formativa em energia limpa, sustentabilidade hospitalar, ESG aplicado à saúde, eficiência energética e inovação social.
Impacto ESG mensurável	O projeto conecta indicadores ambientais, sociais e de governança em uma mesma matriz de monitoramento.	Vincular cada resultado energético a um resultado social, como consultas, exames, atendimentos, formação e proteção de beneficiários.
Replicabilidade	O modelo pode ser adaptado a outras unidades de saúde, hospitais filantrópicos e territórios de fronteira.	Desenvolver manual de replicação, estudo de caso energético e metodologia de conversão da economia em impacto social.
Benefício reputacional para o parceiro	O investidor associa sua marca a uma solução de energia limpa, saúde, Amazônia, proteção humanitária e inovação ESG.	Produzir plano de visibilidade ética, com relatórios, infográficos, vídeo institucional, estudos de caso protegidos e indicadores auditáveis.

24.1. Proposta de Valor para Parceiros de Energia

A proposta de valor para parceiros de energia é clara: apoiar o Amazônia Sem Fronteiras significa demonstrar, na prática e com indicadores verificáveis, que energia limpa pode financiar saúde humanitária e ampliar o acesso a serviços essenciais em um dos territórios mais estratégicos da Amazônia brasileira.

O projeto oferece ao parceiro energético cinco entregas de alto valor institucional:

Entrega estratégica	Valor do projeto para o parceiro
Vitrine tecnológica em saúde	Demonstra aplicação real de energia solar, armazenamento e monitoramento inteligente em ambiente hospitalar.
Impacto social mensurável	Permite associar a economia energética a atendimentos gratuitos, beneficiários, consultas, exames e proteção humanitária.
Narrativa ESG robusta	Integra energia limpa, saúde, migrantes, Amazônia, ODS, formação profissional e governança.
Replicabilidade territorial	Gera metodologia aplicável a outras unidades de saúde em regiões vulneráveis.
Visibilidade qualificada	Produz relatórios, dashboards, estudos de caso e materiais institucionais com evidências de resultado.



24.2. Indicadores Relevantes para Parceiros de Energia

Dimensão	Indicadores estabelecidos
Energia	kWh gerados; energia armazenada; desempenho do BESS; disponibilidade operacional do sistema; redução do consumo da rede; redução da demanda no horário de ponta.
Financeira	Economia mensal e anual; percentual de redução da fatura; valor acumulado economizado; valor convertido em assistência médica gratuita.
Ambiental	Emissões de CO ₂ equivalente evitadas; participação da energia renovável no consumo hospitalar; redução da dependência de energia convencional.
Social	Pessoas únicas atendidas; consultas realizadas; exames laboratoriais; exames de imagem; atendimentos de urgência; retornos e acompanhamentos.
Formação	Pessoas capacitadas em energia limpa, sustentabilidade hospitalar e ESG; horas de formação; certificados emitidos; estudantes envolvidos.
Governança	Relatórios ESG publicados; dashboard atualizado; auditoria ou revisão externa; rastreabilidade da conversão financeira; reuniões de governança.

24.3. Trilha de Formação em Energia Limpa, Sustentabilidade Hospitalar e ESG

O projeto incluirá uma trilha formativa específica voltada a estudantes, profissionais, colaboradores institucionais e, quando viável, jovens migrantes ou participantes da comunidade.

Módulo	Conteúdo	Produto esperado
Energia limpa aplicada à saúde	Conceitos básicos de energia solar, geração distribuída, armazenamento e eficiência energética em serviços essenciais.	Participantes capacitados e certificados.
Sustentabilidade hospitalar	Uso racional de energia, redução de desperdícios, segurança energética, impacto ambiental e gestão de recursos.	Plano simples de boas práticas em sustentabilidade hospitalar.
ESG aplicado à saúde	Indicadores ambientais, sociais e de governança, impacto social, prestação de contas e ODS.	Participantes aptos a compreender e acompanhar indicadores ESG.
Energia e impacto social	Como a economia energética pode ser convertida em serviços gratuitos de saúde e benefícios comunitários.	Compreensão do modelo de conversão social da economia.
Monitoramento e dados	Leitura de dashboards, indicadores de energia, economia, CO ₂ evitado e impacto assistencial.	Apoio à cultura de dados e transparência institucional.

O projeto oferece uma narrativa poderosa, verificável e altamente atrativa para investidores de impacto: energia limpa economiza recursos; os recursos financiam saúde; a saúde protege pessoas; e os dados comprovam impacto na Amazônia brasileira.



25. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO CONSOLIDADO E DETALHADO

O cronograma físico-financeiro do Projeto Amazônia Sem Fronteiras foi organizado em base trimestral, distribuindo os valores conforme o período de início e duração de cada atividade financiável. A lógica de execução concentra maior desembolso no primeiro ano, em razão da implantação da infraestrutura energética sustentável, e mantém execução assistencial, científica, comunicacional, de governança e gestão ao longo dos 24 meses.

O valor global programado é de R\$2.980.320,00, distribuído entre R\$2.455.320,00 do concedente e R\$525.000,00 de contrapartida econômica do proponente.

25.1. Cronograma de desembolso consolidado por ano

Ano	Valor total programado	Concedente	Proponente	% orçamento global	Leitura estratégica
Ano 1	R\$ 1.926.153,34	R\$ 1.731.153,34	R\$ 195.000,00	64,63%	Implantação energética, início da estruturação assistencial, comunicação, governança, formação e início progressivo dos atendimentos. Expansão da operação assistencial, consultas, exames, internações, medicação, ensino, comunicação e governança. Maturidade operacional, produção científica, monitoramento ESG e consolidação dos fluxos assistenciais.
Ano 2	R\$ 1.054.166,66	R\$ 724.166,66	R\$ 330.000,00	35,37%	Consolidação de resultados, avaliação intermediária, continuidade assistencial e fortalecimento da governança. Avaliação final, sustentabilidade, replicabilidade, disseminação de resultados e encerramento técnico-financeiro.
Total	R\$ 2.980.320,00	R\$ 2.455.320,00	R\$ 525.000,00	100,00%	Execução integral do projeto em 24 meses.



25.2. Cronograma detalhado por grupo de despesa

Grupo de despesa	Ano 1	Ano 2	Total
Infraestrutura Energética	R\$ 1.349.570,00	R\$ 0,00	R\$ 1.349.570,00
Atendimento Humanitário	R\$ 455.983,34	R\$ 911.966,66	R\$ 1.367.950,00
Ensino e Pesquisa	R\$ 21.600,00	R\$ 43.200,00	R\$ 64.800,00
Comunicação e Disseminação	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 48.000,00
Governança ESG	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 30.000,00
Gestão do Projeto	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 120.000,00
Total anual	R\$ 1.926.153,34	R\$ 1.054.166,66	R\$ 2.980.320,00

25.3. Cronograma trimestral consolidado

Período	Valor	Percentual
Ano 1 – 1º trimestre	R\$ 699.535,00	23,47%
Ano 1 – 2º trimestre	R\$ 699.535,00	23,47%
Ano 1 – 3º trimestre	R\$ 263.541,67	8,84%
Ano 1 – 4º trimestre	R\$ 263.541,67	8,84%
Ano 2 – 1º trimestre	R\$ 263.541,67	8,84%
Ano 2 – 2º trimestre	R\$ 263.541,67	8,84%
Ano 2 – 3º trimestre	R\$ 263.541,67	8,84%
Ano 2 – 4º trimestre	R\$ 263.541,65	8,84%
Total	R\$ 2.980.320,00	100,00%

A concentração de desembolso nos dois primeiros trimestres do Ano 1 decorre da aquisição e implantação da infraestrutura energética, incluindo equipamentos fotovoltaicos, BESS, implementação do sistema fotovoltaico e implementação do sistema de armazenamento. A partir do segundo trimestre do Ano 1, inicia-se a execução recorrente dos componentes assistenciais, formativos, comunicacionais, de governança e gestão.

25.4. Cronograma físico-financeiro por etapa estratégica

Etapa	Período predominante	Valor Total	Resultado esperado
Implantação da infraestrutura energética	Ano 1, 1º e 2º trimestres	R\$ 1.349.570,00	Sistema fotovoltaico e BESS implantados, testados e aptos a gerar economia operacional.
Estruturação e operação assistencial humanitária	Ano 1 ao Ano 2	R\$ 1.367.950,00	Atendimento de 1.296 beneficiários diretos, com consultas, exames, internações, medicação e atendimento intercultural.
Ensino, pesquisa e integração ensino-serviço	Ano 1 ao Ano 2	R\$ 64.800,00	Remuneração de estagiários acadêmicos, apoio à integração ensino-serviço e produção de evidências.
Comunicação, disseminação e visibilidade	Ano 1 ao Ano 2	R\$ 48.000,00	Produção de materiais informativos, divulgação ética, comunicação institucional e apoio à prestação de contas.
Governança ESG e prestação de contas	Ano 1 ao Ano 2	R\$ 30.000,00	Relatórios ESG, comunicação de resultados, acompanhamento de indicadores e accountability.
Gestão executiva do projeto	Ano 1 ao Ano 2	R\$ 120.000,00	Coordenação estratégica, controle de cronograma, articulação institucional e supervisão da execução.



O cronograma físico-financeiro demonstra coerência entre a lógica de implantação, operação e consolidação do projeto. O primeiro ano concentra os investimentos estruturantes em energia limpa, condição necessária para gerar economia operacional e sustentar a tese de conversão de eficiência energética em assistência humanitária.

Esse desenho financeiro reforça a viabilidade do projeto, pois vincula desembolso a entregas claras, permite monitoramento trimestral, demonstra participação financeira do proponente e assegura que a maior parte dos recursos seja direcionada ao atendimento humanitário e à infraestrutura sustentável que viabiliza o legado do projeto.

26. CONCLUSÃO

O Projeto Amazônia Sem Fronteiras apresenta uma tese de impacto robusta, inovadora e altamente alinhada às agendas internacionais de saúde humanitária, energia limpa, proteção de populações deslocadas, ESG, desenvolvimento sustentável, resiliência climática e fortalecimento de serviços essenciais na Amazônia. Ao responder a um fluxo migratório expressivo no Acre, com 358.439 entradas de estrangeiros entre 2015 e 2026 e saldo migratório positivo de 41.309 pessoas, a proposta se fundamenta em um problema territorial concreto, mensurável e de elevada relevância humanitária.

A meta de 1.296 migrantes e refugiados atendidos ao longo de 24 meses revela-se tecnicamente prudente, realista e proporcional à capacidade operacional proposta. No recorte dos países prioritários do projeto, Peru, Bolívia, Venezuela, Haiti, Senegal, Colômbia e Equador, foram registradas aproximadamente 343.658 entradas no período de 2015 a 2026, o que corresponde a uma média anual estimada de 28.638 entradas de migrantes oriundos desses países vulneráveis. Nesse cenário, a meta média de 432 beneficiários diretos entre o 2º e 4º semestre representa cerca de 2,72% da média anual de entradas desses grupos prioritários, percentual adequado para uma intervenção especializada, gratuita, intercultural e vinculada a consultas, exames, retornos, acompanhamento clínico e proteção humanitária; demonstrando impacto proporcional relevante sem superestimar a capacidade de execução do projeto. Assim, a proposta não pretende cobrir a totalidade do fenômeno migratório no Acre, mas estruturar uma resposta qualificada, mensurável e replicável para os grupos em maior vulnerabilidade, funcionando como modelo demonstrativo de saúde humanitária sustentável em território amazônico de fronteira.



Sua principal força estratégica está na capacidade de integrar, em uma única plataforma, infraestrutura energética sustentável, assistência médica gratuita, atendimento intercultural, proteção social, pesquisa aplicada, formação profissional, governança ESG e produção de evidências científicas. Ao converter a economia gerada por um sistema solar fotovoltaico com BESS em consultas, exames, atendimentos, retornos, acompanhamento clínico e suporte humanitário para migrantes e refugiados vulneráveis, o projeto supera a lógica assistencial pontual e institui um modelo permanente de financiamento social baseado em eficiência energética.

Esse projeto se traduz como um investimento estruturante de impacto, apoiando a implantação de um modelo amazônico replicável de hospital sustentável, capaz de transformar energia limpa em saúde, dignidade, proteção, conhecimento e resiliência social em território de fronteira internacional.

A proposta também se diferencia por incorporar linha de base territorial, Teoria de Mudança a ser validada com parceiros e beneficiários, critérios objetivos de elegibilidade e priorização, protocolo intercultural multilíngue, políticas de salvaguardas, matriz lógica, indicadores SMART, governança com participação social, mecanismos de accountability, proteção de dados, ética em pesquisa, plano de sustentabilidade pós-financiamento e estratégia de replicabilidade; demonstrando assim maturidade técnica, transparência, compromisso com proteção de populações vulneráveis e capacidade de mensuração de resultados.

Investir no Projeto Amazônia Sem Fronteiras é apoiar uma solução amazônica, mensurável, auditável e replicável, capaz de transformar energia limpa em saúde, saúde em proteção humanitária e proteção humanitária em dignidade, resiliência e futuro para migrantes e refugiados em território de fronteira. Trata-se de uma oportunidade qualificada para financiadores que buscam impacto social concreto, legado ambiental, governança responsável e evidências robustas de resultado em uma das regiões mais estratégicas da Amazônia brasileira.

27. MATRIZ DE ANEXOS

Nº	Bloco	Grupo	Documento comprobatório	Finalidade
Anexo 01	Documentos obrigatórios de elegibilidade e due diligence	Institucional	Estatuto Social do iSanté, CNPJ, ata da diretoria, documentos dos representantes legais e certidões de regularidade.	Comprovar existência jurídica, regularidade institucional, legitimidade da representação legal e aptidão formal para receber, executar e prestar contas dos recursos.
Anexo 02	Documentos obrigatórios de elegibilidade e due diligence	Institucional	Alvarás, licenças, e registros sanitários	Comprovar regularidade da estrutura assistencial vinculada ao projeto e conformidade mínima para execução de serviços de saúde.
Anexo 03	Documentos obrigatórios de elegibilidade e due diligence	Capacidade técnica	Currículo institucional do iSanté, portfólio do Grupo Silvestre Santé, estrutura hospitalar disponível e histórico de ações sociais, científicas e assistenciais.	Demonstrar capacidade operacional, assistencial, científica, gerencial e institucional para execução de projeto complexo e de longo prazo.
Anexo 04	Documentos obrigatórios de elegibilidade e due diligence	Equipe-chave	Currículos da coordenação geral, coordenação assistencial, coordenação científica, equipe técnica e profissionais estratégicos.	Comprovar qualificação da equipe responsável pela gestão, execução assistencial, pesquisa, monitoramento, proteção e prestação de contas.
Anexo 05	Documentos estratégicos de pontuação	Produção científica	Relação de publicações científicas, pesquisas clínicas, parcerias acadêmicas e evidências de produção técnico-científica.	Fortalecer a credibilidade do eixo de pesquisa aplicada e demonstrar capacidade de produção de evidências sobre saúde migratória, assistência e impacto.
Anexo 06	Documentos obrigatórios de elegibilidade e due diligence	Parcerias	Termo de cooperação firmado com a UFAC.	Comprovar integração ensino-serviço, cooperação acadêmica, apoio à pesquisa aplicada e formação de estudantes e profissionais.
Anexo 07	Documentos obrigatórios de elegibilidade e due diligence	Parcerias	Carta de apoio do Hospital Silvestre Santé e Acordo de Cooperação Técnica, Científica, Assistencial, Educacional e Financeira	Comprovar disponibilidade da infraestrutura assistencial, cooperação operacional e capacidade de execução dos atendimentos previstos.
Anexo 08	Documentos estratégicos de pontuação	Rede pública e social	Cartas de apoio ou manifestações da rede pública de saúde, assistência social, organizações que atuam com migrantes, unidades de acolhimento ou rede humanitária.	Demonstrar articulação territorial, complementaridade ao SUS, capacidade de encaminhamento, contrarreferência e legitimidade junto à rede de proteção local.
Anexo 09	Documentos técnicos de comprovação da solução	Migração	Base oficial do Observatório da Segurança Pública do Acre sobre movimentos migratórios entre 2015 e 2026.	Comprovar a escala, a continuidade e a relevância territorial do fluxo migratório internacional no Acre.

Nº	Bloco	Grupo	Documento comprobatório	Finalidade
Anexo 10	Documentos técnicos de comprovação da solução	Diagnóstico territorial	Diagnóstico territorial e migratório consolidado, com análise por ano, nacionalidade, saldo migratório e implicações para saúde.	Sustentar tecnicamente a justificativa, a linha de base e a necessidade de resposta humanitária estruturada em saúde.
Anexo 11	Documentos técnicos de comprovação da solução	Energia	Faturas de energia dos últimos 12 a 24 meses.	Comprovar baseline energético, consumo histórico, custo operacional atual e potencial real de economia com a solução proposta.
Anexo 12	Documentos técnicos de comprovação da solução	Energia	Memorial técnico do sistema fotovoltaico e BESS, com premissas de geração, operação, capacidade instalada e economia estimada.	Demonstrar viabilidade técnica, operacional e financeira da infraestrutura energética proposta.
Anexo 13	Documentos técnicos de comprovação da solução	Energia	Composição de investimento do sistema fotovoltaico e BESS.	Comprovar os custos de implantação da solução energética e permitir análise de coerência entre orçamento, equipamentos e resultados esperados.
Anexo 14	Documentos técnicos de comprovação da solução	Energia	Datasheets dos módulos, inversores e BESS.	Comprovar especificações técnicas, desempenho, garantia, compatibilidade e qualidade dos principais equipamentos previstos.
Anexo 15	Documentos técnicos de comprovação da solução	Energia	Certificações INMETRO dos módulos e inversores, quando aplicável.	Comprovar conformidade técnica e regulatória dos equipamentos, reduzindo risco de questionamento técnico pelo financiador.
Anexo 16	Documentos obrigatórios de elegibilidade e due diligence	Orçamento	Plano orçamentário, memória de cálculo e cronograma físico-financeiro.	Demonstrar coerência financeira, custos unitários, contrapartidas, desembolso, compatibilidade entre orçamento, metas e cronograma de execução.